Tesis de Inversión

Pro medicus (PME.AX)

Julio Muñoz Trullenque

18/02/2026

Índice

..... 0

Resumen de la Tesis 3

1. Descripción del Negocio 5

1.1. Qué hace Pro Medicus y que problema resuelve 5

1.2. Server-side streaming vs. PACS legacy: la diferencia técnica 5

1.3. El modelo transaccional por escaneo 6

1.4. Por qué PME no vende hardware 7

2. Historia y Evolución Estratégica 9

2.1. De 1983 a 2009: origen, dificultades y supervivencia 9

2.2. El pivote decisivo: adquisición de Visage Imaging en 2009 9

2.3. La conquista de Norteamérica (2012-2026) 9

3. El Moat: Análisis de la Ventaja Competitiva 11

3.1. Los cinco pilares del moat 11

3.2. La tasa de retención del 100%: el argumento real 11

3.3. Los switching costs en detalle 12

3.4. Por qué los gigantes están perdiendo 12

3.5. Propiedad intelectual y protección tecnológica 14

4. Análisis de la Industria 16

4.1. El mercado de Enterprise Imaging 16

4.2. Tabla comparativa de competidores 17

5. Modelo de Negocio y Análisis Financiero 19

5.1. Evolución del P&L (FY2019-FY2025) 19

5.2. Por qué los márgenes son extraordinarios 20

5.3. Gráfico: Revenue y Net Income (FY2019-FY2025) 20

5.4. Análisis del balance 21

5.5. Análisis del flujo de caja 22

5.6. Gráficos: Márgenes y FCF 23

6. El Management y la Cultura 24

6.1. Sam Hupert y Anthony Hall: founders con skin in the game 24

6.2. La cultura de eficiencia 24

7. Análisis del Contexto de Entrada 26

7.1. Por qué ha caído el 63% 26
7.2. Deterioro operativo vs. ajuste de múltiplos 26
7.3. El buyback del 10% 27
7.3. Conclusión 27
8. Análisis de la Inteligencia Artificial 28
8.1. El argumento bearish 28
8.2. Por qué el argumento es débil 28
8.3. Escenarios de impacto de la IA en PME 29
9. Riesgos e Invalidación de la Tesis 31
9.1. Riesgo de valoración 31
9.2. Riesgo de competencia (Sectra) 31
9.3. Riesgo de concentración geográfica 32
9.4. Riesgo de sucesión 32
9.5. Riesgo de implementación y revenue timing 32
9.6. Otros riesgos: disrupción tecnológica, regulatorio, tipo de cambio 32
10. Valoración 34
10.1. Múltiplos actuales vs. históricos 5Y 34
10.2. Qué tiene que ser verdad a $124 35
10.3. Comparables 36
11. Proyecciones Financieras 37
12. Catalizadores 39
13. Marco de Seguimiento y Señales de Salida 42
13.1. KPIs trimestrales 42
13.2. Señales de invalidación de la tesis 42
13.3. Marco de decisión sobre posición 43
14. Conclusión 44

Resumen de la Tesis

Pro Medicus Limited es una empresa australiana de software de imagen médica que ha resuelto un problema que los gigantes del sector no pudieron resolver durante tres décadas: visualizar imágenes diagnósticas de alta resolución en tiempo real, sin necesidad de descargar gigabytes de datos al ordenador del radiólogo. Su plataforma, Visage 7, opera bajo un modelo de server-side streaming que permite a un hospital con miles de escaneos diarios acceder a cualquier imagen en menos de un segundo desde cualquier navegador web. No requiere hardware especializado, no requiere instalación local, y no requiere mantenimiento por parte del hospital.

La empresa cotiza en el ASX bajo el ticker PME. A fecha 18 de febrero de 2026, su acción ha caído un **63%** desde el máximo histórico de AUD $336 alcanzado meses antes, hasta los AUD $124 a los que inicié la primera entrada. Esta caída se ha producido por la convergencia de tres factores: un ajuste generalizado de múltiplos en el sector tecnológico, preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en la radiología, y unos resultados del primer semestre del año fiscal 2026 ligeramente por debajo del consenso de analistas. Ninguno de estos factores refleja un deterioro operativo del negocio.

Los números hablan por sí solos. Pro Medicus ha crecido sus ingresos a una tasa compuesta anual del **30%** durante los últimos cinco años, pasando de AUD $57M en FY2020 a AUD $213M en FY2025. El beneficio neto ha crecido aún más rápido, al 38% anual, reflejando el apalancamiento operativo inherente a un modelo de software puro. Los márgenes operativos superan el 74%, el retorno sobre el capital invertido es del 26%, y la empresa genera más de AUD $100M anuales de flujo de caja libre con apenas 132 empleados. No tiene deuda financiera relevante y mantiene una posición de caja neta de AUD $172M.

La ventaja competitiva de Pro Medicus es profunda y comprobable. Desde la adquisición de Visage Imaging en 2009, ninguno de sus clientes ha abandonado la plataforma. Cero. Esa tasa de retención del 100% no es marketing; es consecuencia de unos switching costs reales que incluyen la integración con sistemas hospitalarios complejos, el reentrenamiento de cientos de radiólogos y técnicos, y el riesgo operativo de migrar un sistema del que depende literalmente la atención al paciente. Los contratos son típicamente de siete a diez años, con cláusulas de renovación automática, y el modelo transaccional por escaneo alinea directamente los intereses de PME con el volumen de actividad del hospital.

Los competidores principales, GE Healthcare, Philips, Siemens y Agfa, llevan décadas vendiendo sistemas PACS (Picture Archiving and Communication System) basados en arquitecturas obsoletas que requieren descargas locales masivas. Sectra, la empresa sueca que representa la competencia más seria, opera con una tecnología capaz pero no ha logrado replicar la velocidad de Visage 7 en entornos de alto volumen. Pro Medicus ha ganado consistentemente los contratos más grandes del mercado norteamericano: Intermountain

Healthcare, Harvard, Mayo Clinic, y Kaiser Permanente, el mayor sistema hospitalario integrado de Estados Unidos.

Respecto a la inteligencia artificial, el argumento bearish sostiene que la IA reemplazará al radiólogo y, por tanto, eliminará la necesidad de software de visualización. Este argumento es débil por varias razones. La IA diagnóstica no elimina la imagen; la necesita como input. Los modelos de IA médica requieren aprobación FDA individual para cada indicación, los hospitales necesitan un humano en el bucle por razones legales y de responsabilidad, y la propia plataforma Visage 7 está posicionada como capa de distribución para herramientas de IA de terceros. La IA es, en mi opinión, un catalizador positivo para PME, no una amenaza existencial.

A AUD $124, el mercado está valorando a Pro Medicus en el **percentil 5** de su P/E histórico de los últimos cinco años, con un múltiplo P/E TTM de aproximadamente 84x frente a una mediana histórica de 159x. El EV/EBIT TTM de 77x se sitúa igualmente en el percentil más bajo del rango histórico. Esto significa que el mercado está pagando el nivel de valoración más bajo en media década por un negocio que sigue creciendo al 30%, mantiene márgenes del 74%, no ha perdido un solo cliente, y acaba de anunciar un programa de recompra de acciones del 10% ejecutado a través de Goldman Sachs.

Nuestro escenario base proyecta un precio objetivo a tres años de AUD $280-$320, lo que implica un retorno potencial del 126-158% desde el precio de entrada. El escenario bull, que asume una reversión parcial de múltiplos y un crecimiento sostenido por encima del 28%, apunta a AUD $380-$420. El escenario bear, que contempla una compresión adicional y un crecimiento más moderado, sitúa el suelo razonable en torno a AUD $160-$180, lo que aun representaría un retorno positivo del 29-45% a tres años.

La asimetría del retorno potencial es el elemento central de esta tesis. En el peor de los escenarios razonables, se perdería poco o ganaría modestamente. En el mejor escenario, más que duplicamos la inversión. En el escenario más probable, generaría un retorno superior al 125%. Este perfil asimétrico es exactamente lo que busco: situaciones donde la probabilidad y la magnitud del upside superan ampliamente el downside.

Los riesgos existen y los abordo con honestidad en esta tesis. PME sigue siendo una empresa cara en términos absolutos. La concentración geográfica en Estados Unidos es elevada. Los fundadores tienen más de 60 años y no existe un plan de sucesión público. El crecimiento podría desacelerarse si los ciclos de implementación de nuevos contratos se alargan. Pero la pregunta correcta no es si Pro Medicus tiene riesgos, sino si la caída del 63% refleja adecuadamente esos riesgos o si el mercado ha sobrerreaccionado. Mi conclusión es que ha sobrerreaccionado, y que la oportunidad asimétrica que presenta esta situación justifica una posición con convicción.

1. Descripción del Negocio

1.1. Qué hace Pro Medicus y que problema resuelve

Pro Medicus desarrolla y comercializa software de imagen médica para hospitales y sistemas de salud. Su producto principal, la plataforma **Visage 7**, es lo que en la industria se conoce como un Enterprise Imaging Platform: un sistema centralizado que permite a los radiólogos visualizar, manipular e informar estudios de imagen diagnóstica, incluyendo tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, radiografías, mamografías, ecografías y estudios de medicina nuclear.

El problema que resuelve es más sutil de lo que parece. Un hospital grande genera diariamente miles de estudios de imagen, cada uno compuesto por cientos o miles de imágenes individuales que pueden pesar varios gigabytes. El radiólogo necesita abrir esos estudios, compararlos con estudios previos del mismo paciente, manipular el contraste, hacer zoom, medir estructuras y, finalmente, emitir un informe. Durante décadas, los sistemas PACS (Picture Archiving and Communication System, el estandar de almacenamiento y visualización de imágenes médicas) resolvieron este flujo descargando el estudio completo al ordenador del radiólogo antes de que este pudiera empezar a trabajar. En estudios pesados, esto podía significar minutos de espera.

Visage 7 resuelve ese cuello de botella con una arquitectura radicalmente distinta. En lugar de descargar el estudio completo, el servidor procesa y renderiza las imágenes de forma remota y transmite solo los pixeles necesarios al navegador del radiólogo, en tiempo real. Es lo mismo que hace Netflix con el video, pero aplicado a imágenes médicas de altísima resolución que requieren precisión diagnóstica. El radiólogo ve la imagen en menos de un segundo, independientemente de su tamaño o complejidad.

1.2. Server-side streaming vs. PACS legacy: la diferencia técnica

La diferencia entre la arquitectura de Visage 7 y la de un PACS tradicional es la diferencia entre ver una película en streaming y descargarla entera antes de reproducirla. En un sistema legacy, el cliente (el ordenador del radiólogo) solicita el estudio completo al servidor, lo descarga, y solo entonces puede empezar a visualizarlo. Esto requiere estaciones de trabajo potentes con pantallas especializadas, conexiones de red de alta capacidad, y una infraestructura de almacenamiento local que hay que mantener y actualizar periódicamente.

En el modelo de Visage 7, el procesamiento se realiza íntegramente en el servidor. La imagen se renderiza en la nube o en el data center del hospital, y lo que llega al navegador del radiólogo es un flujo de pixeles ya procesados. Esto tiene cuatro consecuencias prácticas de enorme importancia. Primera: la velocidad de visualización es prácticamente instantánea, independientemente del tamaño del estudio. Segunda: el radiólogo puede trabajar desde

cualquier dispositivo con un navegador web, lo que se conoce como zero footprint. Tercera: las actualizaciones del software se despliegan centralmente sin intervención del hospital. Y cuarta: el hospital elimina la necesidad de invertir en hardware de visualización especializado.

El siguiente diagrama ilustra esta diferencia arquitectónica:

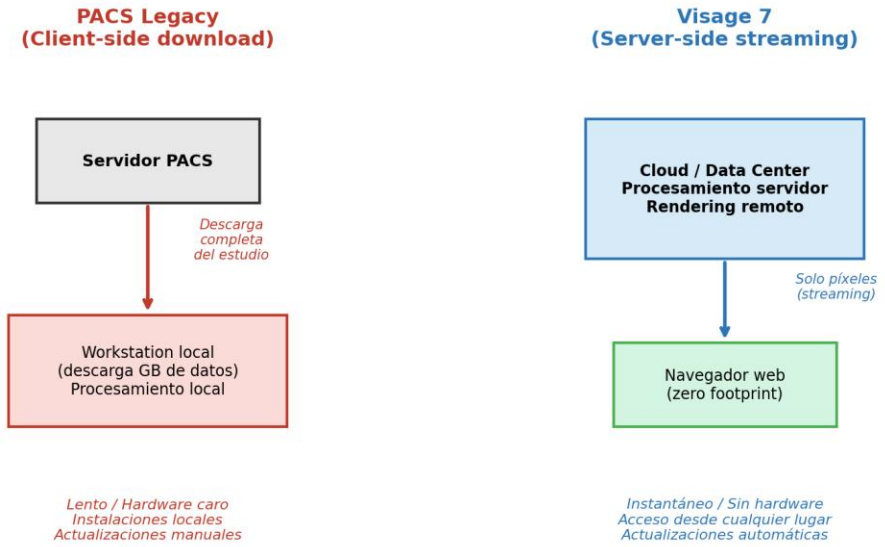

Figura 1: Comparación de arquitecturas. PACS legacy (izquierda) vs. Visage 7 server-side streaming (derecha).

Esta diferencia no es un detalle técnico menor; es la razón por la que Pro Medicus puede cobrar por escaneo y escalar sin fricción, mientras que sus competidores siguen atados a modelos de venta de licencias y hardware con ciclos de actualización costosos.

1.3. El modelo transaccional por escaneo

Pro Medicus no vende licencias perpetuas. Su modelo de ingresos es transaccional: cobra una cantidad fija por cada escaneo que un hospital procesa a través de Visage 7. Cuantas más tomografías, resonancias y radiografías realiza el hospital, más paga a PME. Esto tiene implicaciones profundas para la dinámica de ingresos.

En primer lugar, los ingresos crecen orgánicamente con el volumen de actividad del hospital, sin necesidad de vender contratos adicionales. El envejecimiento de la población, el aumento de las pruebas diagnósticas per capita y la mayor resolución de las imágenes (que genera más escaneos por estudio) son vientos de cola estructurales que impulsan el volumen independientemente del esfuerzo comercial de PME. En segundo lugar, el modelo alinea perfectamente los intereses: si el hospital crece, PME crece con él. Si el hospital implementa

nuevas modalidades de imagen, PME captura ese volumen adicional sin renegociación contractual.

Los contratos son típicamente de siete a diez años de duración, con fases de implementación que pueden extenderse entre 12 y 24 meses. Durante la fase de implementación, los ingresos reconocidos son mínimos, lo que genera una dinámica de backlog significativa: Pro Medicus puede tener contratos firmados cuyo impacto en la cuenta de resultados no se materializara hasta trimestres posteriores. Este detalle es importante para entender por qué los ingresos del primer semestre de FY2026 pueden estar por debajo del consenso sin que ello implique deterioro del negocio.

1.4. Por qué PME no vende hardware

La decisión de no vender hardware no es accidental; es la consecuencia lógica de la arquitectura server-side. Si el procesamiento ocurre en el servidor y el radiólogo solo necesita un navegador, el hardware de visualización deja de ser responsabilidad de PME. Esta decisión explica directamente la estructura de márgenes de la empresa. Los competidores que venden sistemas PACS integrados con estaciones de trabajo, servidores de almacenamiento y contratos de mantenimiento de hardware cargan con costes variables significativos que erosionan sus márgenes. Pro Medicus, en cambio, opera con una estructura de costes mayoritariamente fija, compuesta por salarios de ingenieros de software, infraestructura de cloud computing y un equipo comercial reducido. Cada escaneo adicional procesado a través de la plataforma genera ingresos con un coste marginal que tiende a cero.

El resultado es un negocio con márgenes operativos superiores al 74% y una generación de flujo de caja libre que supera el 48% de los ingresos. Muy pocos negocios de software empresarial alcanzan estos niveles, y los que lo hacen suelen operar en mercados mucho menos defensivos que la imagen médica.

Para dimensionar la magnitud de esta diferencia: un contrato típico de PACS legacy con un hospital de 500 camas puede implicar una inversión inicial de USD $2-5M en licencias, hardware e implementación, seguida de pagos anuales de mantenimiento del 15-20% del coste inicial. El hospital paga mucho por adelantado, tiene incentivos a retrasar las actualizaciones, y el proveedor tiene incentivos a vender la siguiente versión en lugar de mejorar la actual. El modelo de PME invierte esta dinámica: el hospital no paga nada por adelantado, solo paga por uso, y tanto el hospital como PME se benefician de que el sistema funcione de forma óptima en todo momento.

Hay un efecto secundario de este modelo que rara vez se menciona en los análisis: la **previsibilidad de los ingresos**. Un contrato transaccional de siete años con un hospital grande genera un flujo de ingresos que es más predecible que una licencia perpetua, porque el volumen de escaneos de un hospital es relativamente estable año a año, con una tendencia

secular al alza. No es un SaaS puro con riesgo de churn mensual; es un contrato de infraestructura crítica que se comporta más como un peaje sobre la actividad hospitalaria.

Esta previsibilidad tiene un segundo derivado importante para el inversor: reduce el riesgo de sorpresas negativas en los resultados trimestrales. Los ingresos de PME están anclados en volúmenes reales de actividad médica, no en decisiones de compra discrecionales de los CIOs. Salvo un evento catastrófico que reduzca dramáticamente el volumen de pruebas diagnósticas en todo el sistema sanitario (algo que ni siquiera la pandemia de COVID-19 logró de forma sostenida), la base de ingresos es sólida.

2. Historia y Evolución Estratégica

2.1. De 1983 a 2009: origen, dificultades y supervivencia

Pro Medicus fue fundada en 1983 en Melbourne, Australia, por Sam Hupert, un radiólogo de formación que vio antes que muchos que la digitalización transformaría la práctica de la radiología. Durante sus primeras dos décadas, la empresa operó como un proveedor regional de software de informes radiológicos y sistemas de gestión de prácticas médicas. Su producto principal, llamado ProMedicus, era un RIS (Radiology Information System, el sistema que gestiona el flujo de trabajo y los informes del departamento de radiología) orientado al mercado australiano.

La empresa salió a bolsa en el ASX en el año 2000, en plena burbuja tecnológica. Los años siguientes no fueron fáciles. El mercado australiano era pequeño, la competencia internacional era feroz, y Pro Medicus carecía de un producto diferenciado que justificase su expansión fuera de Oceanía. Los ingresos oscilaban entre AUD $9M y AUD $19M sin una tendencia clara de crecimiento, y la empresa dependía en gran medida de contratos gubernamentales australianos. Para 2008, muchos inversores habrían descartado a PME como una empresa mediana sin ambición global.

2.2. El pivote decisivo: adquisición de Visage Imaging en 2009

En 2009, Pro Medicus realizó la adquisición que cambió radicalmente su trayectoria: la compra de Visage Imaging, una empresa con sede en Berlin que había desarrollado una tecnología revolucionaria de visualización de imágenes médicas basada en server-side rendering. Visage Imaging nació del entorno de investigación europeo en procesamiento de imágenes y había construido un motor de renderización capaz de procesar volúmenes de datos masivos en tiempo real desde el servidor, algo que ningún sistema PACS comercial ofrecía en ese momento.

La adquisición costó relativamente poco, fue financiada sin deuda, y transformó a Pro Medicus de un proveedor regional de RIS a una empresa con un producto tecnológicamente disruptivo de alcance global. Sam Hupert y Anthony Hall, el CEO y el CFO respectivamente desde los orígenes de la empresa, reconocieron que la tecnología de Visage tenía el potencial de redefinir la categoría. Lo que hicieron a continuación fue igual de importante: en lugar de intentar crecer rápidamente mediante adquisiciones adicionales o contratación masiva, adoptaron una estrategia de penetración disciplinada, apuntando directamente a los sistemas hospitalarios más grandes y exigentes del mundo.

2.3. La conquista de Norteamérica (2012-2026)

El primer gran contrato estadounidense llegó en 2012. Desde entonces, la trayectoria ha sido una escalada sistemática hacia clientes cada vez más grandes. Intermountain Healthcare en

2017 fue un punto de inflexión: un sistema de salud con decenas de hospitales que eligió a PME sobre los competidores. Luego vinieron los nombres que consolidaron la credibilidad de la empresa a nivel global: Harvard en 2020, Mayo Clinic poco después, y Kaiser Permanente en 2023, un contrato de proporciones enormes dado que Kaiser gestiona más de 39 hospitales y 700 instalaciones médicas en Estados Unidos.

Cada uno de estos contratos funcionó como validación acumulativa. Un hospital mediano puede arriesgarse con un proveedor poco conocido; Kaiser Permanente no. Que los sistemas hospitalarios más prestigiosos del mundo hayan elegido a una empresa australiana de 132 empleados sobre divisiones de GE, Philips y Siemens que facturan miles de millones es, en sí mismo, la prueba más potente de la superioridad del producto.

La cronología de los contratos enterprise revela un patrón deliberado. Pro Medicus no persiguió volumen; persiguió señalización. Cada contrato fue elegido no solo por su valor económico, sino por el efecto que tendría en la percepción del mercado. Ganar Intermountain demostró que Visage 7 podía funcionar a escala. Ganar Harvard demostró que podía funcionar en el entorno académico más exigente del mundo. Ganar Mayo Clinic demostró que los mejores hospitales del planeta confiaban en la plataforma. Y ganar Kaiser Permanente, con sus más de 12 millones de miembros, demostró que podía funcionar en el ecosistema de managed care más grande de Estados Unidos.

Hay otro aspecto de la estrategia de conquista norteamericana que merece atención: la paciencia. Los ciclos de venta enterprise en imagen médica pueden extenderse durante 18-36 meses. Los procesos de evaluación implican demostraciones técnicas exhaustivas, pilotos en entornos reales, negociaciones contractuales complejas, y aprobaciones por múltiples comités hospitalarios. Pro Medicus nunca intento acortar estos ciclos ofreciendo descuentos agresivos o condiciones financieras atípicas. En su lugar, dejo que la tecnología hablara por sí misma. Esta disciplina comercial es coherente con la filosofía general de la empresa: hacer pocas cosas, pero hacerlas excepcionalmente bien.

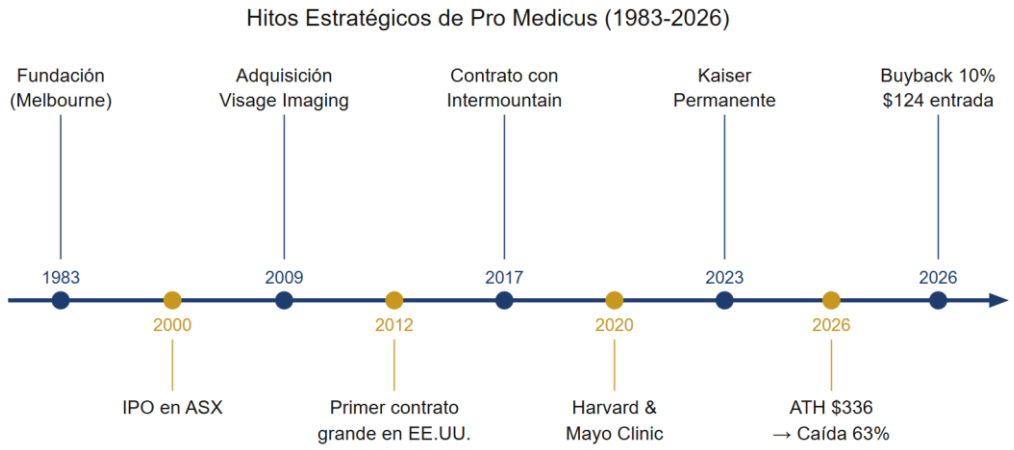

Figura 2: Hitos estratégicos de Pro Medicus, desde su fundacion en 1983 hasta la oportunidad de entrada en 2026.

3. El Moat: Análisis de la Ventaja Competitiva

3.1. Los cinco pilares del moat

La ventaja competitiva de Pro Medicus no descansa en un único factor sino en la interacción de cinco elementos que se refuerzan mutuamente. El primero y más relevante son los **switching costs**, los costes que un hospital asume si decide cambiar de proveedor de imagen médica. El segundo es una ventaja tecnológica real y demostrable: la velocidad de Visage 7 en entornos de alto volumen sigue siendo superior a la de cualquier competidor. El tercero es el modelo **capital-light**, que permite a PME escalar sin inversiones intensivas en hardware o infraestructura. El cuarto son los contratos de larga duración, típicamente de siete a diez años, que proporcionan visibilidad sobre los ingresos futuros y reducen la volatilidad. Y el quinto, menos evidente pero igualmente importante, es el efecto reputacional: cada contrato con un hospital de prestigio refuerza la posición de PME en los procesos de selección posteriores.

3.2. La tasa de retención del 100%: el argumento real

Desde la adquisición de Visage Imaging en 2009, Pro Medicus no ha perdido un solo cliente. Ni uno. Esta cifra es tan inusual que merece un examen crítico: puede que sea retención genuina o puede que sea simplemente un negocio demasiado joven como para haber experimentado el ciclo completo de renovación. Evaluemos ambas posibilidades.

La primera renovación significativa de contratos enterprise se produjo alrededor de 2019-2020, cuando los primeros clientes grandes alcanzaron el final de su período contractual inicial. Todos renovaron. La segunda ola de renovaciones, correspondiente a contratos firmados entre 2017 y 2020, está ocurriendo ahora. Hasta la fecha, el patrón se mantiene. Esto sugiere que la retención del 100% no es un artefacto estadístico del tamaño de la muestra, sino un reflejo de switching costs genuinamente elevados.

Para entender por qué, consideremos lo que implica migrar un hospital grande de Visage 7 a un sistema alternativo. El departamento de radiología de un hospital universitario puede tener entre 50 y 200 radiólogos, cada uno con flujos de trabajo personalizados dentro de la plataforma. Visage 7 está integrado con el sistema de historia clínica electrónica del hospital, con los sistemas de programación de citas, con los equipos de imagen de distintos fabricantes, y con herramientas de comunicación interdepartamental. Una migración requeriría meses de planificación, semanas de implementación paralela, reentrenamiento de todo el personal médico y técnico, y aceptar un período de riesgo operativo durante el cual cualquier fallo podría afectar directamente al diagnóstico de pacientes. Ningún CIO de un hospital toma esa decisión a menos que exista una razón operativa crítica para hacerlo.

3.3. Los switching costs en detalle

Los costes de cambio en imagen médica son multidimensionales. El coste directo de una nueva implementación de PACS se mide en millones de dólares, pero ese es solo el componente más visible. Existen costes ocultos que a menudo superan el coste de la propia tecnología.

El **coste de integración** es el primero. Un sistema de imagen médica no opera de forma aislada, debe comunicarse con decenas de otros sistemas hospitalarios a través de protocolos como HL7 y DICOM. Cada interfaz debe configurarse, probarse y validarse. En un hospital grande, esto puede implicar entre 30 y 50 integraciones individuales, cada una con sus propias particularidades y requisitos de testing. El **coste de reentrenamiento** es el segundo. Un radiólogo que ha trabajado durante años con Visage 7 tiene sus atajos memorizados, sus hanging protocols configurados y sus preferencias de visualización definidas. Migrar a otro sistema significa reaprender todo. Multiplicado por 100 o 200 radiólogos, más los técnicos, los administradores de sistemas y el personal de soporte, el impacto en productividad durante los primeros meses es significativo.

El **coste de riesgo operativo** es quizá el más importante. Un hospital no puede permitirse que el sistema de imagen falle durante la transición. Una tomografía de urgencia que no se visualiza a tiempo puede tener consecuencias clínicas graves. Ese riesgo es el freno último contra cualquier migración que no esté absolutamente justificada. Y hay un cuarto coste que rara vez se menciona: el **coste político interno**. El CIO que propone cambiar el sistema de imagen médica de un hospital universitario se expone a la resistencia de los radiólogos que ya están cómodos con el sistema actual, a la presión del departamento financiero por la inversión requerida, y al escrutinio de la junta directiva si algo sale mal durante la transición. Es mucho más fácil, y mucho más seguro para la carrera profesional, renovar el contrato existente.

La combinación de estos cuatro tipos de costes crea una barrera de salida que es, en la práctica, casi infranqueable. No es que ningún hospital vaya a cambiar jamás; es que el umbral de motivación necesario para hacerlo es extraordinariamente alto. El competidor que quiera desplazar a Visage 7 no solo necesita ser un poco mejor; necesita ser dramáticamente superior en dimensiones que el hospital valore, y además necesita ofrecer una transición con riesgo prácticamente nulo. Hasta la fecha, nadie ha cumplido ese estándar.

3.4. Por qué los gigantes están perdiendo

GE Healthcare, Philips y Siemens Healthineers son empresas con divisiones de software de imagen médica que facturan miles de millones. Cada una tiene presencia global, relaciones comerciales de décadas con hospitales, y presupuestos de I+D que empequeñecen el de Pro Medicus. Sin embargo, llevan años perdiendo los contratos más grandes frente a una empresa de 132 personas. La razón es estructural, no coyuntural.

Estos gigantes desarrollaron sus sistemas PACS hace décadas sobre arquitecturas client-server que descargaban los estudios completos a la estación de trabajo. Con el tiempo, fueron añadiendo capas de complejidad: módulos de cardiología, integración con equipos propios, herramientas de productividad. El resultado son plataformas monolíticas, pesadas y difíciles de actualizar. Reescribir estas plataformas desde cero para adoptar una arquitectura de streaming requeriría años de desarrolló, migraciones dolorosas de clientes existentes, y la canibalización de líneas de negocio de hardware que generan ingresos significativos. Es el clásico dilema del innovador descrito por Clayton Christensen: las empresas dominantes no pueden adoptar la tecnología disruptiva sin destruir su propio modelo de negocio.

Sectra, la empresa sueca, merece una mención aparte. Sectra opera en el mismo segmento y ofrece una plataforma enterprise de calidad reconocida. Tiene una presencia fuerte en Escandinavia y Europa, y ha ganado contratos importantes en Estados Unidos. Sin embargo, su arquitectura, aunque moderna, no iguala la velocidad pura de Visage 7 en los benchmarks de alto volumen que publican consultoras como KLAS Research. En evaluaciones directas (head-to-head), PME ha prevalecido consistentemente en los procesos de selección de los sistemas hospitalarios más grandes. Esto no significa que Sectra sea un competidor irrelevante; es, de hecho, la amenaza competitiva más cedible, y la tratamos con detalle en la sección de riesgos.

Merece la pena profundizar en por qué los competidores no pueden simplemente reescribir sus plataformas. GE Healthcare Centricity PACS tiene una base instalada de miles de hospitales en todo el mundo. Reescribir el producto desde cero para adoptar server-side streaming requeriría entre 3 y 5 años de desarrolló, durante los cuales la base instalada seguiría en el producto legacy. El equipo de desarrolló tendría que mantener simultáneamente dos bases de código, con las ineficiencias que eso implica. Los clientes existentes necesitarían ser migrados al nuevo sistema, un proceso que generaría resistencia y potencialmente pérdida de clientes. Y todo esto mientras PME sigue ganando los contratos más grandes del mercado.

Philips tiene un problema adicional: su estrategia de plataforma integrada (que combina imagen, monitorización, y gestión clínica) crea interdependencias que hacen aún más difícil modularizar y reescribir el componente de imagen de forma aislada. Siemens Healthineers, por su parte, ha optado por concentrar sus recursos de software en teamplay, su plataforma de datos clínicos en la nube, lo que significa que la inversión en su PACS legacy recibe menos atención y recursos de los que necesitaría para competir seriamente con Visage 7.

El resultado neto es que los competidores están atrapados en un equilibrio subóptimo: no pueden abandonar sus productos legacy porque generan ingresos recurrentes, pero no pueden modernizarlos lo suficiente como para competir con una plataforma nativa de streaming. Mientras tanto, Pro Medicus avanza acumulando los contratos enterprise más valiosos, que son los más difíciles de recuperar una vez perdidos.

La siguiente tabla compara la posición competitiva de Pro Medicus frente a los principales competidores en las dimensiones más relevantes:

Dimensión	Pro Medicus	Sectra	GE Healthcare	Philips	Agfa
Arquitectura	Server-side streaming	Híbrida moderna	Client-side legacy	Client-side legacy	Client-side legacy
Velocidad (alto volumen)	Superior	Buena	Media	Media	Media-baja
Modelo ingresos	Transaccional por escaneo	Licencia + mantenimiento	Licencia + hardware	Licencia + hardware	Licencia + mantenimiento
KLAS Score (2024)	94.2	91.5	78.3	80.1	72.6
Retention rate	100%	~95%	~80%	~82%	~75%
Margen EBIT	>74%	~25%	~15%	~14%	~8%
Zero footprint	Si	Parcial	No	Parcial	No

Tabla 1: Comparativa de moat. Pro Medicus vs. principales competidores (datos estimados a febrero 2026).

3.5. Propiedad intelectual y protección tecnológica

La pregunta que todo gestor debería hacerse al analizar una empresa cuya ventaja competitiva descansa en una tecnología propietaria es: ¿qué impide que un competidor con recursos replique lo que hace Pro Medicus? La respuesta tiene 3 capas, de menor a mayor relevancia estructural.

Primera capa: patentes registradas

Pro Medicus describe explícitamente en su propia web la velocidad de Visage 7 como *"patented speed"*, confirmando que los mecanismos de procesamiento de imagen están protegidos por patentes registradas. El origen de estas patentes es la adquisición de Visage Imaging en 2009: Mercury Computer Systems había desarrollado y registrado las patentes fundacionales de server-side rendering aplicado a imagen médica, y ese portfolio fue el activo central de la transacción.

Segunda capa: base de código propietaria sin dependencias externas

Un detalle técnico con implicaciones competitivas directas, documentado en la web oficial de la empresa: *"Visage 7 is a single code base, and does not use external or third party code for advanced capabilities."* La plataforma no depende de librerías de terceros para sus funcionalidades críticas, el motor de compresión, streaming, renderizado 3D/4D y gestión de imagen está escrito y mantenido íntegramente por el equipo de Berlín. La implicación es doble: no existe riesgo de dependencia de proveedores externos, y cualquier competidor que quiera igualar las capacidades de Visage 7 tendría que reescribir desde cero un sistema con más de 15 años de refinamiento continuo y optimización.

Tercera capa: el know-how acumulado como barrera no replicable

Esta es la barrera más sólida y la menos formal. Las patentes tienen una vida limitada de 20 años, y algunas del portfolio original de Visage Imaging están envejeciendo. Lo que no envejece es el know-how acumulado por los aproximadamente 40 ingenieros del centro de Berlín: físicos, matemáticos e ingenieros especializados en computación de alto rendimiento que llevan más de una década optimizando un único problema técnico muy específico. Este tipo de expertise profundo no se puede contratar ni comprar en 2-3 años; tardó 15 en construirse.

El perfil del CTO global, Dr. Malte Westerhoff, PhD en Ciencias de la Computación y Matemáticas por la Free University of Berlin, co-fundador de Indeed-Visual Concepts, con publicaciones y patentes propias en visualización científica, ilustra la densidad de talento técnico que sostiene esta ventaja. Retener a este equipo es, en la práctica, el activo de IP más difícil de atacar y el que ningún competidor ha logrado replicar en más de una década de intentarlo.

4. Análisis de la Industria

4.1. El mercado de Enterprise Imaging

El mercado global de Enterprise Imaging, que incluye PACS, VNA (Vendor Neutral Archive, un sistema de almacenamiento de imágenes independiente del fabricante del equipo) y plataformas de visualización avanzada, está valorado en aproximadamente **USD $2.310M** en 2025, con proyecciones de alcanzar los USD $4.120M en 2030, lo que implica un CAGR del 12.3%. Este crecimiento está impulsado por cuatro fuerzas estructurales que merece la pena desglosar.

La primera es el aumento del volumen de imágenes diagnósticas. La combinación de poblaciones envejecidas en los mercados desarrollados, mayor acceso a la sanidad en mercados emergentes, y protocolos clínicos que incorporan más pruebas de imagen por paciente genera un crecimiento secular del volumen de escaneos. Solo en Estados Unidos, el número de estudios de imagen ha crecido a un ritmo del 4-5% anual durante la última década.

La segunda es el aumento del peso por estudio. Las imágenes médicas son cada vez más pesadas. Un estudio de tomografía computarizada hace diez años podía generar 200-300 imágenes; hoy, un estudio de alta resolución puede superar las 3.000. Los estudios de resonancia cardiaca, las reconstrucciones 3D y los protocolos de medicina nuclear generan volúmenes de datos que saturan los sistemas legacy, pero que Visage 7 procesa con fluidez gracias a su arquitectura de streaming.

La tercera fuerza es la migración a la nube. Los hospitales están abandonando progresivamente los data centers propios en favor de infraestructuras cloud que ofrecen escalabilidad, redundancia y menores costes de mantenimiento. Este movimiento favorece estructuralmente a las plataformas nativas de cloud como Visage 7 frente a los sistemas legacy que fueron diseñados para operar on-premise.

La cuarta es la escasez de radiólogos. El deficit de radiólogos es un problema creciente en Estados Unidos, Europa y Australia. Un radiólogo que no tiene que esperar minutos para cargar un estudio es un radiólogo que puede informar más estudios por hora. La velocidad de Visage 7 no es solo una ventaja técnica; es una herramienta de productividad en un contexto de escasez de capital humano.

Hay una quinta fuerza que merece mención separada: la **consolidación hospitalaria**. Los sistemas de salud en Estados Unidos llevan dos décadas fusionándose, creando redes cada vez más grandes que gestionan decenas o centenas de centros. Esta consolidación favorece a proveedores de plataformas enterprise como Pro Medicus, porque un sistema hospitalario grande quiere un único proveedor de imagen para todos sus centros, no un mosaico de sistemas legacy distintos en cada hospital. Cuanto mayor es el sistema hospitalario, mayor es

la ventaja competitiva de Visage 7, porque la arquitectura centralizada de server-side streaming es inherentemente más eficiente a escala que los sistemas descentralizados de los competidores.

La intersección de estas cinco fuerzas crea un TAM (Total Addressable Market, mercado total direccionable) que está creciendo más rápido de lo que sugieren las cifras de mercado de Enterprise Imaging aisladas. El mercado relevante para Pro Medicus no es solo la venta de software de imagen; es la captura del gasto sanitario en productividad radiológica, un mercado significativamente más grande que el de licencias de PACS.

Esta lógica de centralización no se limita a radiología. Pro Medicus ha lanzado ya Visage 7 | Cardiology Imaging, un módulo en producción con herramientas nativas para ecocardiografía y cateterismo cardiaco, incluido en contratos enterprise recientes como UCHealth. Los departamentos de cardiología han operado históricamente con sistemas propios, separados del PACS radiológico, dominados por los mismos fabricantes legacy que PME ya está desplazando en radiología. Si Visage 7 replica ese patrón en cardiología, el TAM direccionable se amplía de forma significativa, y el switching cost en cada hospital existente se profundiza: un cliente que centraliza imagen radiológica y cardiaca en una sola plataforma tiene aún menos razones para cambiar de proveedor.

4.2. Tabla comparativa de competidores

El panorama competitivo de imagen médica esta fragmentado entre grandes conglomerados industriales y especialistas puros. La siguiente tabla resume la posición de los actores más relevantes según Klas research, firma independiente y consultora líder en investigación de mercados:

Empresa	KLAS Score	Modelo Ingresos	Presencia Geográfica	Fortaleza Principal	Debilidad Principal
Pro Medicus (Visage 7)	94.2	Transaccional por escaneo	EE.UU. (90%) Australia	Velocidad pura; zero footprint	Concentración geográfica
Sectra	91.5	Licencia + mantenimiento	Escandinavia; EE.UU. creciente	Plataforma integrada; fuerte en Europa	Menor velocidad en alto volumen
GE Healthcare (Centricity)	78.3	Licencia + hardware	Global	Base instalada enorme	Arquitectura obsoleta
Fujifilm (Synapse)	82.1	Licencia + hardware	Japon; EE.UU.	Integración con equipos propios	Lenta innovación en software
Agfa HealthCare	72.6	Licencia + mantenimiento	Europa; Latinoamerica	Presencia en mercados nicho	Pérdida de cuota; problemas financieros

Merge (IBM/Merative)	70.4	Licencia	EE.UU.	Integración con Watson (limitada)	Producto descuidado tras adquisición

Tabla 2: Principales competidores en Enterprise Imaging (KLAS scores actualizados a 2024; datos estimados donde no hay fuente pública).

El dato más relevante de esta tabla no es el KLAS score en sí mismo, sino la tendencia: Pro Medicus y Sectra han ganado consistentemente puntuación en los últimos cinco años, mientras que los competidores industriales la han perdido.

KLAS Research pública anualmente encuestas de satisfacción basadas en entrevistas con usuarios reales de cada plataforma. La metodología mide dimensiones como velocidad de visualización, estabilidad del sistema, calidad del soporte técnico, facilidad de uso, y disposición a recomendar el producto a otros hospitales. Pro Medicus ha ocupado la primera posición en la categoría de Enterprise Imaging durante tres años consecutivos, con una ventaja creciente sobre Sectra en la dimensión de velocidad y sobre todos los competidores en la dimensión de soporte técnico, a pesar de tener un equipo de soporte significativamente más pequeño. Esto sugiere que la arquitectura server-side, al centralizar la complejidad en el servidor y simplificar el cliente, reduce inherentemente la necesidad de soporte, lo que a su vez mejora la experiencia del usuario.

Fujifilm Synapse merece una mención específica como posible competidor emergente. Fujifilm ha invertido agresivamente en su division de informática médica y tiene la ventaja de ofrecer integración nativa con sus propios equipos de imagen. Sin embargo, su plataforma sigue dependiendo de una arquitectura híbrida que no iguala la velocidad de Visage 7 en entornos de alto volumen, y su presencia enterprise en Estados Unidos es limitada. Monitorizaremos la evolución de Fujifilm como potencial amenaza, especialmente si realiza adquisiciones en el espacio de visualización avanzada.

5. Modelo de Negocio y Análisis Financiero

5.1. Evolución del P&L (FY2019-FY2025)

La cuenta de resultados de Pro Medicus refleja la mecánica de un negocio de software con apalancamiento operativo excepcional. Los ingresos se han cuadruplicado en seis años, pero los beneficios se han multiplicado por seis, porque la base de costes crece mucho más lentamente que los ingresos. Esta dinámica es el sello distintivo de los mejores negocios de software del mundo. La siguiente tabla desglosa la evolución:

AUD M	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Revenue	50.1	56.8	67.9	93.5	124.9	161.4	212.9
YoY Growth	**+39%**	**+13%**	**+19%**	**+38%**	**+34%**	**+29%**	**+32%**
Gross Profit	48.7	56.4	46.7	92.9	92.4	122.2	212.6
EBITDA	31.5	37.7	49.5	69.6	91.7	120.7	164.9
EBITDA Mg	**62.9%**	**66.4%**	**73.0%**	**74.5%**	**73.4%**	**74.8%**	**77.4%**
EBIT	25.5	30.1	42.4	62.4	83.9	112.2	157.6
EBIT Mg	**50.8%**	**52.9%**	**62.4%**	**66.8%**	**67.2%**	**69.5%**	**74.0%**
Net Income	19.1	23.1	30.9	44.4	60.6	82.8	115.2
Net Mg	**38.2%**	**40.6%**	**45.5%**	**47.6%**	**48.6%**	**51.3%**	**54.1%**
EPS (AUD)	0.18	0.22	0.30	0.43	0.58	0.79	1.10

Tabla 3: Cuenta de resultados resumida FY2019-FY2025 (en millones AUD). Fuente: informes anuales PME.

Varios elementos merecen atención. Primero, el crecimiento de ingresos ha mantenido una tasa superior al 19% en todos los años, incluyendo FY2020, un ano marcado por la pandemia global que redujo temporalmente el volumen de escaneos. Segundo, los márgenes EBITDA han escalado del 63% al 77%, demostrando que el apalancamiento operativo no es teórico sino real y medible. Tercero, el EPS se ha multiplicado por seis en seis años, pasando de AUD $0.18 a AUD $1.10, con un CAGR del 35%.

El patrón de crecimiento de revenue merece un análisis más detallado. Los AUD $212.9M de FY2025 representan un crecimiento del 32% sobre FY2024, pero la distribución de ese crecimiento entre las distintas fuentes es informativa. Aproximadamente dos tercios del

incremento proviene de la activación de contratos firmados en años anteriores que entraron en fase de producción plena durante el ejercicio. El tercio restante corresponde a crecimiento orgánico del volumen de escaneos en contratos existentes y a nuevos contratos firmados durante el propio FY2025. Esta composición del crecimiento es importante porque sugiere que una parte significativa del revenue de los próximos ejercicios ya está contractualmente comprometida, pendiente únicamente de que los hospitales completen la fase de go-live.

También es revelador analizar la evolución del coste de ventas. En FY2025, el coste de ventas fue de apenas AUD $0.3M, una cifra que parece anómalamente baja y que refleja la reclasificación contable de determinados costes hacia gastos operativos. Más relevante es el gasto total operativo (SGA más I+D) de AUD $55M, que ha crecido un 12% interanual frente a un crecimiento de revenue del 32%. Esta tijera entre crecimiento de ingresos y crecimiento de gastos es la esencia del apalancamiento operativo: por cada dólar adicional de revenue, entre 70 y 80 céntimos caen directamente al beneficio operativo.

5.2. Por qué los márgenes son extraordinarios

Un margen EBIT del 74% en un negocio de software empresarial B2B no es simplemente bueno, es excepcional incluso para los estándares del sector. Para contextualizarlo: Veeva Systems, la referencia en software vertical para farma, opera con márgenes EBIT del 35-40%. Sectra, el competidor más directo de PME, ronda el 25%. La media del sector SaaS es del 20-25%.

La explicación radica en la estructura de costes. Pro Medicus tiene 132 empleados. Ciento treinta y dos. Para generar AUD $213M de ingresos, eso supone **AUD $1.6M de revenue por empleado**, una métrica que supera a prácticamente cualquier empresa de software del mundo. La empresa no tiene fuerza de ventas masiva porque sus contratos los gana en procesos de evaluación técnica donde el producto habla por sí mismo. No tiene equipos de implementación porque el despliegue de Visage 7 es centralizado y no requiere presencia física permanente en el hospital. No tiene costes de hardware porque no vende hardware. Y no tiene deuda, lo que elimina los gastos financieros.

Lo que resulta aún más notable es que estos márgenes siguen expandiéndose. A medida que la base de contratos crece y los hospitales existentes generan más volumen de escaneos, los ingresos incrementales se convierten en beneficio casi puro. Cada dólar adicional de revenue que genera un contrato existente tiene un coste marginal cercano a cero, porque la infraestructura ya está desplegada y el equipo de soporte es el mismo.

5.3. Gráfico: Revenue y Net Income (FY2019-FY2025)

El gráfico siguiente ilustra la trayectoria de crecimiento simultaneo de ingresos y beneficio neto. Obsérvese como el gap entre ambas barras se estrecha, lo que refleja la expansión de márgenes:

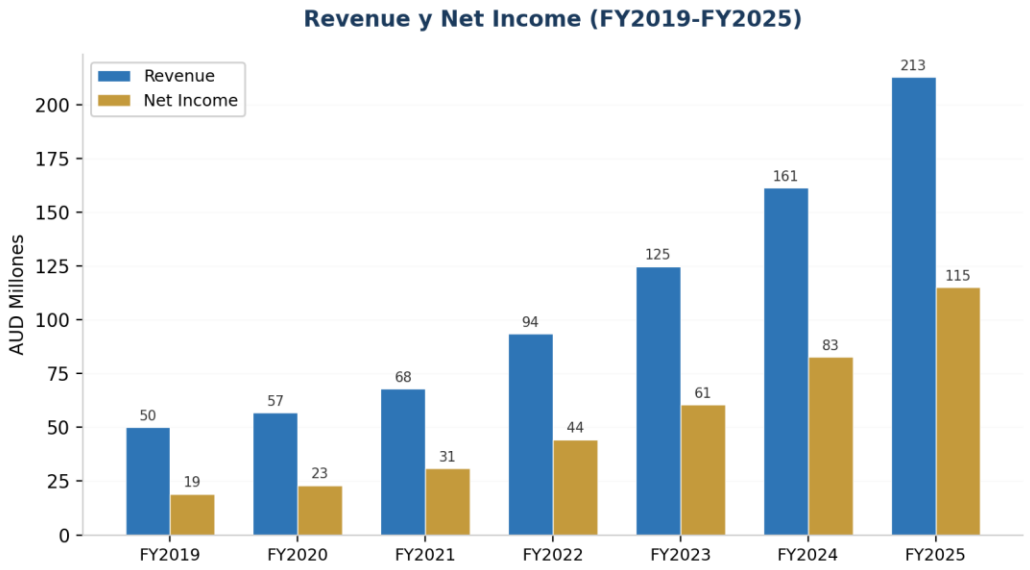

Figura 3: Revenue y Net Income FY2019-FY2025 (AUD millones). El estrechamiento del gap refleja expansión de márgenes.

5.4. Análisis del balance

El balance de Pro Medicus es el de una empresa gestionada con una disciplina financiera fuera de lo común. A cierre de FY2025, la posición de caja e inversiones a corto plazo asciende a **AUD $209M**, frente a una deuda financiera total de apenas AUD $2.9M (compuesta íntegramente por pasivos de arrendamiento operativo, sin deuda bancaria real). La caja neta es, por tanto, de aproximadamente **AUD $206M**.

Los activos intangibles de AUD $20.8M corresponden fundamentalmente a los costes de desarrolló capitalizados de Visage 7, y el goodwill es exactamente cero, lo que indica que la empresa no ha pagado primas elevadas por adquisiciones. El patrimonio neto asciende a AUD $257M y ha crecido un 37% interanual, financiado íntegramente por los beneficios retenidos.

El capital circulante es holgado: AUD $280M de activo corriente frente a AUD $43M de pasivo corriente, lo que deja un fondo de maniobra de AUD $237M. Esta es una empresa que no tiene ninguna presión financiera, que no necesita captar capital, y que puede operar durante años sin generar un solo dólar adicional de ingresos sin verse amenazada.

Un detalle del balance que merece atención es la evolución de los ingresos diferidos (deferred revenue). El total de ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, asciende a AUD $48.5M en FY2025, frente a AUD $42.9M en FY2024. Este incremento del 13% indica que los clientes están prepagando por servicios que aún no se han prestado, lo que es un indicador adelantado de revenue futuro. Los ingresos diferidos en Pro Medicus corresponden típicamente a fases de implementación de contratos nuevos: el hospital firma el contrato,

comienza a pagar, pero el reconocimiento de ingresos transaccionales plenos no se produce hasta que el sistema está en pleno funcionamiento (go-live).

Otro indicador relevante es la evolución de las cuentas por cobrar: AUD $64.2M en FY2025 frente a AUD $48.1M en FY2024, un incremento del 34% que está alineado con el crecimiento de revenue del 32%. El ratio de cuentas por cobrar sobre revenue se mantiene estable en torno al 30%, lo que indica que no hay deterioro en los plazos de cobro ni en la calidad crediticia de los clientes. Los hospitales y sistemas de salud son, en general, pagadores fiables, aunque lentos, y Pro Medicus no ha reportado provisiones significativas por incobrables en ningún ejercicio.

5.5. Análisis del flujo de caja

La generación de flujo de caja libre es el indicador definitivo de la calidad de un negocio, y Pro Medicus sobresale de forma espectacular. El FCF (flujo de caja libre, definido como el flujo operativo menos las inversiones de capital) alcanzo los **AUD $104M** en FY2025, frente a AUD $80M en FY2024, un crecimiento del 30%. La tasa de conversión de FCF sobre net income es típicamente superior al 85%, lo que indica que los beneficios contables se convierten en efectivo real con mínima erosión.

Las inversiones de capital (capex) son reducidas y consisten fundamentalmente en desarrolló de software capitalizado, con cifras que oscilan entre AUD $6M y AUD $9M anuales. No hay necesidad de invertir en plantas, equipos o infraestructura pesada. La relación capex/revenue es inferior al 4%, lo que es característico de un modelo puramente digital.

La política de dividendos de Pro Medicus complementa el perfil de generación de caja. La empresa ha mantenido un dividendo creciente durante más de una década, con un payout ratio que oscila entre el 40% y el 50% del beneficio neto. En FY2025, el dividendo total pagado fue de AUD $49.1M, lo que representa un payout del 43% sobre el beneficio neto de AUD $115.2M. A precio de entrada de AUD $124, el dividend yield es del 0.45%, modesto en términos absolutos pero coherente con una empresa que reinvierte la mayor parte de sus beneficios en crecimiento orgánico.

Lo que resulta más relevante que el yield actual es la tasa de crecimiento del dividendo: un 34% anual en los últimos cinco años. Si esta tasa se mantiene, lo cual es plausible dado el crecimiento del FCF subyacente, el dividendo por acción en FY2028 sería aproximadamente el doble del actual, lo que elevaría el yield on cost al 0.9-1.0%. Para un inversor con horizonte largo, la combinación de crecimiento de capital y crecimiento de dividendos genera un perfil de retorno total atractivo.

Un último punto sobre la asignación de capital. La decisión de lanzar el buyback del 10% en febrero de 2026 sugiere que la directiva está priorizando la devolución de capital a los accionistas sobre las adquisiciones. Esto es coherente con la filosofía histórica de Hupert y

Hall: crecer orgánicamente, no a golpe de talonario. En un entorno donde muchas empresas de software utilizan la caja para adquisiciones que destruyen valor, la disciplina de capital de PME es un diferenciador significativo.

5.6. Gráficos: Márgenes y FCF

Los dos gráficos siguientes muestran la evolución de los márgenes operativos y del flujo de caja libre durante la última década:

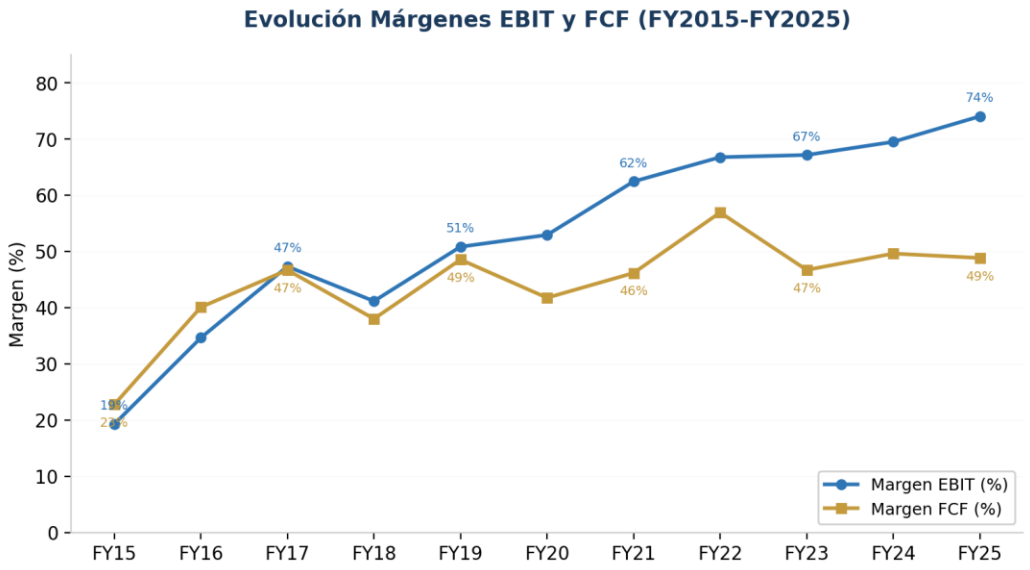

Figura 4: Márgenes EBIT y FCF FY2015-FY2025. La expansión sostenida refleja el apalancamiento operativo del modelo.

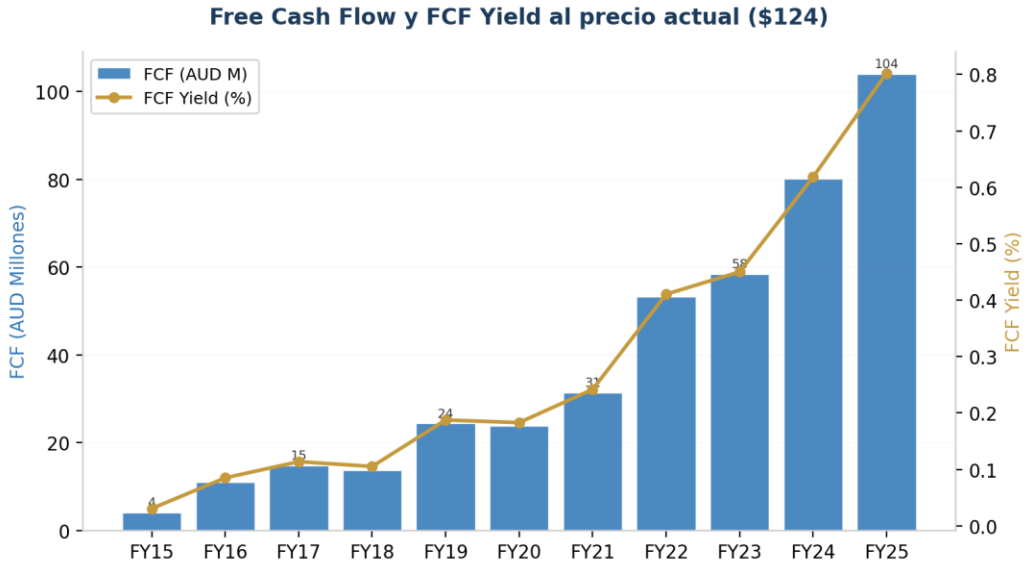

Figura 5: FCF y FCF Yield al precio actual de $124. El yield actual del 0.8% es bajo en términos absolutos pero coherente con un negocio en crecimiento del 30%.

6. El Management y la Cultura

6.1. Sam Hupert y Anthony Hall: founders con skin in the game

Sam Hupert, CEO, y Anthony Hall, CFO, fundaron Pro Medicus y la han dirigido durante más de cuatro décadas. Entre ambos poseen aproximadamente el **46%** del capital de la empresa, una participación valorada en miles de millones de dólares australianos incluso al precio deprimido actual. Esta alineación de intereses no es retorica: cuando el 46% de tu patrimonio personal depende de las decisiones que tomas como gestor, la calidad de esas decisiones tiende a ser significativamente superior a la media.

La trayectoria de Hupert y Hall demuestra tres cualidades que valoro especialmente en un equipo directivo. La primera es **paciencia estratégica**: tardaron una década después de la adquisición de Visage Imaging en construir la base de clientes enterprise que hoy genera la mayor parte de los ingresos. No intentaron crecer a golpe de adquisiciones ni quemaron caja en expansión prematura. La segunda es **disciplina de capital**: la empresa no ha emitido acciones significativas, no se ha endeudado, y ha financiado todo su crecimiento con flujo de caja operativo. La tercera es **resistencia a la presión externa**: cuando los inversores y analistas pedían un despliegue más agresivo, Hupert y Hall mantuvieron su enfoque en ganar los contratos correctos en lugar de maximizar el número de contratos a cualquier precio.

6.2. La cultura de eficiencia

El dato de los 132 empleados no es solo una curiosidad; es la expresión de una filosofía empresarial. Pro Medicus opera con la mentalidad de que cada persona contratada debe multiplicar el valor, no simplemente añadirlo. El equipo de ingeniería es reducido y altamente especializado, concentrado en Melbourne (Australia) y en San Diego (Estados Unidos). No hay capas de gestión intermedia innecesarias, no hay divisiones burocráticas, y no hay equipos de soporte masivos porque la arquitectura del producto minimiza la necesidad de soporte.

Los **AUD $1.6M de revenue por empleado** sitúan a Pro Medicus en el percentil más alto de eficiencia operativa entre todas las empresas de software del mundo. Como referencia, Veeva Systems genera aproximadamente USD $750K por empleado, y Salesforce genera alrededor de USD $550K. PME dobla o triplica estas cifras con un negocio que es argumentablemente más defensivo.

Las señales de alineación entre gestión e inversores van más allá de la participación accionarial. La empresa ha mantenido un dividendo creciente sin interrupciones, ha evitado la dilución de accionistas, y el reciente anunció del buyback del 10% refuerza la señal de que la directiva considera que el mercado está infravalorando el negocio. Cuando los fundadores

que poseen el 46% del capital deciden recomprar acciones con el dinero de la empresa, la señal informativa es inequívoca.

Hay un aspecto de la cultura de Pro Medicus que no se refleja en los números pero que es perceptible en las conference calls y en las interacciones con analistas: la ausencia de lenguaje corporativo inflado. Hupert y Hall no hablan de sinergias, de ecosistemas transformadores, ni de plataformas de innovación disruptiva. Hablan de contratos ganados, de hospitales satisfechos, de márgenes mejorados y de caja generada. Es una comunicación que prioriza la sustancia sobre el estilo, y que contrasta notablemente con la retórica habitual de los equipos directivos del sector tecnológico. Esta sobriedad comunicativa es, en sí misma, un indicador de cultura empresarial sana.

La compensación ejecutiva también merece atención. Los salarios base de Hupert y Hall son modestos para los estándares del sector (inferiores a AUD $1M anuales cada uno), y los incentivos a largo plazo están vinculados a métricas de rendimiento operativo y al precio de la acción. No hay paquetes de stock options dilutivos ni golden parachutes excesivos. La mayor parte del patrimonio de ambos fundadores está en las acciones que ya poseen, no en opciones que aún no han ejercido. Este alineamiento es genuino, no cosmético.

Un riesgo que abordamos en la sección correspondiente pero que vale la pena adelantar aquí es la sucesión. Hupert y Hall son insustituibles en el sentido de que han construido la cultura y la estrategia de la empresa durante cuatro décadas. Sin embargo, el equipo técnico que lidera el desarrolló de Visage 7 opera con un alto grado de autonomía y experiencia acumulada. La transición eventual de liderazgo no tiene por qué ser destructiva si se gestiona con tiempo y cuidado, pero su ausencia de planificación pública es una preocupación legitima que monitorizaremos de cerca.

7. Análisis del Contexto de Entrada

7.1. Por qué ha caído el 63%

La caída del 63% desde el máximo histórico de AUD $336 hasta los AUD $124 actuales se explica por la convergencia simultanea de tres factores, ninguno de los cuales representa un deterioro fundamental del negocio.

El primer factor es el **miedo a la inteligencia artificial**. La narrativa predominante en los mercados durante 2025 ha sido que la IA generativa y los modelos de visión artificial pueden sustituir al radiólogo humano, lo que eliminaría la necesidad de software de visualización. Esta narrativa ha provocado una venta generalizada de acciones en el sector de healthtech, afectando desproporcionadamente a empresas como PME que cotizan con múltiplos elevados. En la sección 8 desmontamos este argumento con detalle.

El segundo factor son los **resultados del primer semestre de FY2026**, que estuvieron ligeramente por debajo del consenso de analistas. Los ingresos de HY26 fueron inferiores a las expectativas, pero la explicación proporcionada por la empresa es coherente con su modelo de negocio: varios contratos grandes firmados recientemente se encontraban en fase de implementación (go-live) durante ese período, lo que retrasa el reconocimiento de ingresos. Esto no es un fenómeno nuevo en PME; ha ocurrido en ciclos anteriores y siempre se ha resuelto con una aceleración posterior una vez que los contratos se activan.

El tercer factor es la **rotación sectorial** más amplia. Los inversores han rotado desde acciones de crecimiento con múltiplos elevados hacia sectores defensivos y value, en un entorno de tipos de interés más altos de lo esperado. Esta rotación no discrimina entre empresas de calidad y empresas mediocres; simplemente vende todo lo que tenga un P/E por encima de un umbral determinado.

7.2. Deterioro operativo vs. ajuste de múltiplos

La distinción crítica que debe hacer todo inversor ante una caída de esta magnitud es si refleja un deterioro del negocio subyacente o un simple ajuste del precio que el mercado está dispuesto a pagar por ese negocio. En el caso de PME, la evidencia apunta claramente a lo segundo.

Los márgenes EBIT han seguido expandiéndose. La tasa de retención de clientes sigue siendo del 100%. El pipeline de contratos es robusto. El backlog de implementaciones pendientes es elevado. No hay deterioro de las métricas operativas en ninguna dimensión observable. Lo que ha cambiado es exclusivamente el múltiplo de valoración: el mercado ha pasado de pagar un P/E de 200x en el pico a un P/E de 84x en el mínimo. Pero 84x sigue siendo un múltiplo elevado en términos absolutos, y creemos que es justificado para un negocio con este perfil de crecimiento, márgenes y durabilidad.

7.3. El buyback del 10%

En febrero de 2026, Pro Medicus anunció un programa de recompra de acciones por un máximo de 10.4 millones de acciones, equivalente al **10% del capital en circulación**. La ejecución se ha delegado a Goldman Sachs bajo un plan de operaciones automáticas. Este es el mayor programa de recompra en la historia de la empresa, y su timing no es accidental.

Los buybacks son una herramienta financiera que puede usarse bien o mal. Cuando una empresa recompra acciones mientras cotiza cerca de máximos históricos, es a menudo un uso ineficiente del capital. Pero cuando una empresa con un balance sin deuda, AUD $209M de caja, y fundadores que poseen el 46% del capital decide recomprar el 10% de sus acciones después de una caída del 63%, la señal es poderosa. Los insiders están diciendo, con su dinero, que creen que la acción esta significativamente infravalorada.

7.3. Conclusión

Vale la pena reflexionar sobre la psicología del mercado que ha generado esta oportunidad. Pro Medicus fue, durante años, una de las acciones favoritas del mercado australiano. Fondos de crecimiento, ETFs tematicos de salud digital, y carteras de momentum la incluían como posición core. Cuando el sentimiento cambió, la misma popularidad que había impulsado la acción se convirtió en un lastre: los mismos fondos que la habían comprado con entusiasmo la vendieron con urgencia. Las ventas forzadas de ETFs y fondos que enfrentan reembolsos no discriminan entre empresas que se han deteriorado y empresas que simplemente han pasado de moda.

Este patrón, una empresa de calidad excepcional que cae porque el momentum y el sentimiento cambian, no porque los fundamentales cambien, se ha repetido muchas veces en la historia de los mercados. Adobe en 2022. Visa en 2018. Constellation Software en 2015. En cada caso, la empresa recupero y supero sus máximos previos en un plazo de 2-3 años porque la máquina generadora de beneficios seguía intacta. No afirmo que PME sea idéntica a estos casos, pero el patrón es reconocible.

Hay un argumento adicional que refuerza la oportunidad: el **flow de información asimétrica**. Los analistas sell-side que cubren PME operan con modelos que extrapolan linealmente los últimos dos trimestres. Cuando HY26 decepciono, revisaron a la baja sus estimaciones para todo FY2026 y FY2027, generando una cascada de rebajas de precio objetivo que amplifico la caída. Pero estos modelos no capturan adecuadamente la dinámica de backlog: los contratos firmados que aún no se han activado. El inversor que tiene una visión más completa del pipeline, incluyendo los contratos en fase de implementación, puede estimar que el gap entre los resultados reportados y el potencial real de ingresos es significativamente mayor de lo que el consenso refleja.

8. Análisis de la Inteligencia Artificial

8.1. El argumento bearish

El argumento más repetido contra Pro Medicus en los últimos meses es que la inteligencia artificial terminara por reemplazar al radiólogo humano, y que cuando eso ocurra, la demanda de software de visualización de imágenes se desplomara. Si un algoritmo puede diagnosticar una radiografía de torax con mayor precisión que un radiólogo, el razonamiento sigue, ¿para qué necesita el hospital una plataforma sofisticada de visualización?

Este argumento ha contribuido significativamente a la compresión de múltiplos de PME. Tiene una lógica superficial atractiva, pero colapsa cuando se examina con rigor clínico, regulatorio y tecnológico.

8.2. Por qué el argumento es débil

Hay cinco razones por las cuales la IA no elimina la necesidad de la plataforma de visualización, al menos en un horizonte relevante para esta tesis.

Primera: la IA necesita la imagen como input.

Los modelos de visión artificial para diagnóstico médico no eliminan la imagen; la requieren. Un algoritmo que detecta nódulos pulmonares necesita que el estudio de tomografía exista, se almacene, y se presente al radiólogo junto con el resultado del algoritmo. La plataforma PACS o enterprise imaging sigue siendo imprescindible como infraestructura de flujo de trabajo.

Segunda: la regulación exige un humano en el bucle.

La FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, y los organismos regulatorios de la mayoría de países desarrollados exigen que un médico humano valide cualquier diagnóstico antes de que tenga implicaciones clínicas. Los algoritmos de IA médica están aprobados como herramientas de ayuda al diagnóstico (CADe, Computer-Aided Detection, y CADx, Computer-Aided Diagnosis), no como sustitutos del radiólogo. Cambiar este marco regulatorio requeriría décadas, no años.

Tercera: la responsabilidad legal.

Si un algoritmo de IA emite un diagnóstico erróneo que resulta en daño al paciente, ¿Quién es responsable? El fabricante del algoritmo, el hospital, el radiólogo que no lo superviso, ¿el desarrollador del PACS? Este vacío de responsabilidad no tiene solución legal clara, y hasta que la tenga, los hospitales no delegaran diagnósticos a la IA sin supervisión humana.

Cuarta: la precisión real de la IA.

Un paper de investigadores de Stanford publicado en 2026, titulado sobre el concepto de 'epistemic mimicry', demostró que los modelos de IA médica actuales son capaces de imitar patrones diagnósticos con alta precisión en datasets estandarizados, pero fallan de formas impredecibles cuando se enfrentan a presentaciones atípicas, patologías raras, o imágenes adquiridas en condiciones no estándar. La IA médica no sabe lo que no sabe, y eso la hace peligrosa como sistema autónomo.

Quinta: la plataforma como capa de distribución de IA.

Visage 7 no compite con la IA; **la integra.** La plataforma tiene una arquitectura abierta que permite a desarrolladores de algoritmos de IA conectar sus herramientas como módulos dentro del flujo de trabajo del radiólogo. Esto convierte a PME en un recipiente de la IA médica, no en su víctima. Cuantas más herramientas de IA se desarrollen, más valor tiene la plataforma como punto de integración.

8.3. Escenarios de impacto de la IA en PME

Escenario	Descripción	Impacto en PME	Probabilidad
Bull	IA como catalizador: PME se convierte en plataforma de distribución de herramientas IA, cobra por integración	Ingresos adicionales por módulo IA; mayor stickiness de la plataforma	55%
Base	IA complementaria: herramientas de IA se integran en PACS pero no alteran el modelo de negocio fundamental	Neutral a ligeramente positivo; mayor productividad del radiólogo impulsa volumen	35%
Bear	IA sustitutiva: reguladores permiten IA autónoma; se reduce la necesidad de visualización humana	Reducción gradual de volumen por escaneo; impacto en 5-10 años	10%

Tabla 5: Escenarios de impacto de la IA en el modelo de negocio de Pro Medicus.

En resumen, asignamos una probabilidad combinada del 90% a escenarios donde la IA tiene un efecto neutral o positivo en Pro Medicus, y solo un 10% al escenario genuinamente adverso, que además se materializaría en un horizonte de 5 a 10 años.

Hay un elemento adicional que refuerza nuestra posición. La historia de la tecnología médica demuestra que las herramientas de productividad rara vez eliminan al profesional; lo hacen más productivo, lo que paradójicamente aumenta la demanda del servicio. La ecografía no elimino al radiólogo; creo una nueva subespecialidad. La resonancia magnética no elimino la tomografía; se añadió al arsenal diagnóstico. La IA diagnóstica seguirá el mismo patrón:

se añadirá como una capa más de herramientas que el radiólogo utiliza, no como un sustituto del radiólogo en sí. Y cada una de esas capas necesita integrarse en una plataforma de visualización que las orqueste.

El mercado ha tratado la narrativa de IA como una amenaza binaria: o la IA elimina a los radiólogos o no lo hace. La realidad es un espectro mucho más matizado, y en la inmensa mayoría de ese espectro, Pro Medicus se beneficia. Solo en el extremo más radical del espectro, un escenario donde la IA autónoma está aprobada regulatoriamente, los hospitales confían en ella sin supervisión humana, y la necesidad de visualización de imágenes desaparece, PME se ve perjudicada. Ese extremo es, a día de hoy, ciencia ficción.

9. Riesgos e Invalidación de la Tesis

Toda tesis de inversión debe ser tan honesta con lo que puede salir mal como con lo que puede salir bien. Los riesgos de Pro Medicus son reales, y el hecho de que creamos en la oportunidad no significa que ignoremos los escenarios adversos. Esta sección detalla cada riesgo con su probabilidad estimada, su impacto potencial, y la señal concreta que indicaría que se está materializando.

9.1. Riesgo de valoración

Incluso después de una caída del 63%, Pro Medicus cotiza con un P/E TTM de 84x. Esto es elevado en términos absolutos, aunque bajo en términos relativos a su propio historial. El riesgo es que el mercado decida que un P/E de 60-70x es el nuevo equilibrio para PME, lo que implicaría una caída adicional del 30-40% desde los niveles actuales. Esto podría ocurrir si el crecimiento de ingresos desacelera por debajo del 20% durante varios trimestres consecutivos, o si los tipos de interés se mantienen en niveles que comprimen estructuralmente los múltiplos de crecimiento. La señal sería un P/E que se mantiene por debajo de 80x durante dos trimestres consecutivos sin recuperación, acompañado de una desaceleración del crecimiento.

Para contextualizar este riesgo: durante el período 2020-2024, el P/E medio de PME fue de aproximadamente 160x. El mercado pago esos múltiplos porque percibía a PME como un compounder de calidad extraordinaria en un entorno de tipos bajos. Con tipos más altos, las tasas de descuento suben, los múltiplos se comprimen, y la pregunta es dónde se estabiliza el nuevo equilibrio. Nuestra hipótesis es que un P/E de 80-120x es sostenible para un negocio con este perfil, lo que sitúa el rango de valoración razonable entre AUD $180 y AUD $320. Pero debemos ser honestos: si el mercado decide que PME merece el mismo múltiplo que Sectra (60-70x), el precio podría estabilizarse en torno a AUD $90-100, lo que representaría una pérdida del 20-30% sobre nuestro precio de entrada. Es un riesgo que aceptamos conscientemente porque creemos que la probabilidad es baja, pero no insignificante.

9.2. Riesgo de competencia (Sectra)

Sectra es un competidor serio con una plataforma moderna, un equipo técnico competente, y una presencia creciente en Estados Unidos. Si Sectra comienza a ganar contratos enterprise de gran escala que previamente habrían ido a PME, la narrativa de dominio competitivo se debilita. La señal específica sería que Sectra ganase dos o más contratos de sistemas hospitalarios con más de 10 hospitales en un período de 12 meses, especialmente si esos contratos son en procesos donde PME también compitió.

9.3. Riesgo de concentración geográfica

Aproximadamente el **90%** de los ingresos de Pro Medicus provienen de Estados Unidos. Esto genera una dependencia crítica de las dinámicas del mercado sanitario norteamericano: cambios regulatorios en Medicare/Medicaid, recortes presupuestarios hospitalarios, o una desaceleración económica que reduzca los volúmenes de atención podrían impactar significativamente a PME. La señal sería una caída sostenida del volumen de escaneos en Estados Unidos superior al 5% durante más de dos trimestres, o cambios regulatorios que afecten directamente al reembolso de pruebas de imagen.

9.4. Riesgo de sucesión

Sam Hupert tiene 70 años y Anthony Hall tiene más de 65. Ambos llevan más de 40 años al frente de la empresa. No existe un plan de sucesión público, y la cultura de eficiencia extrema de PME está indisolublemente ligada a su liderazgo. La salida de Hupert o Hall, especialmente si es imprevista, podría generar incertidumbre significativa en el mercado. La señal sería cualquier comunicación oficial sobre cambios en el equipo directivo, especialmente si va acompañada de la contratación de directivos externos provenientes de culturas corporativas radicalmente distintas.

9.5. Riesgo de implementación y revenue timing

Los contratos de Pro Medicus tienen ciclos de implementación de 12 a 24 meses. Si estos ciclos se alargan sistemáticamente, el reconocimiento de ingresos se retrasa y las expectativas de analistas se incumplen repetidamente. El HY26 por debajo de consenso puede ser un fenómeno temporal explicado por go-lives retrasados, pero también podría ser la primera señal de un patrón más estructural. La señal sería que los ingresos permanezcan por debajo del consenso durante tres trimestres consecutivos, o que la empresa comunique retrasos sistematicos en la fase de go-live.

9.6. Otros riesgos: disrupción tecnológica, regulatorio, tipo de cambio

El riesgo de disrupción tecnológica plantea si alguien puede construir un competidor de Visage 7 en cinco años. Es posible, pero improbable: la base de código de Visage 7 se ha desarrollado durante más de quince años, esta optimizada para el procesamiento de imágenes médicas específicamente, y la validación clínica de un nuevo sistema requiere años de pruebas en entornos hospitalarios reales.

Para entender la magnitud de esta barrera, consideremos lo que implicaría. Un nuevo entrante necesitaría, primero, reclutar un equipo de ingenieros con experiencia específica en procesamiento de imágenes médicas y protocolos DICOM, un talento escaso y concentrado en un puñado de empresas. Segundo, necesitaría desarrollar un motor de rendering server-side capaz de procesar volúmenes masivos con latencia inferior a un segundo, algo que

requiere años de optimización a nivel de kernel y GPU. Tercero, necesitaría obtener las certificaciones regulatorias necesarias (FDA 510(k) clearance, marcado CE, certificacion TGA en Australia). Y cuarto, necesitaría convencer a un hospital grande de que confié su flujo de trabajo radiológico a un producto sin historial de producción. Cada uno de estos pasos es un filtro que reduce dramáticamente el número de competidores potenciales.

El riesgo regulatorio abarca cambios en normativas de privacidad de datos médicos (HIPAA en EE.UU., GDPR en Europa, la Australian Privacy Act) que podrían aumentar los costes de compliance o restringir la capacidad de procesamiento remoto de imágenes. Este riesgo afecta a todo el sector, no solo a PME, y la empresa tiene un historial sólido de cumplimiento regulatorio. Sin embargo, una regulación que prohibiese o restringiese significativamente el procesamiento de imágenes médicas fuera de las instalaciones del hospital podría impactar negativamente al modelo de cloud computing que sustenta la escalabilidad de Visage 7.

La tabla siguiente resume los riesgos con su evaluación:

Riesgo	Prob.	Impacto	Señal de alerta	Mitigante
Valoración (compresión)	Media	Alto	P/E < 80x sostenido + desaceleración	Crecimiento 30% justifica prima
Competencia (Sectra)	Media-baja	Alto	Sectra gana 2+ contratos grandes	Ventaja técnica; retención 100%
Concentración EE.UU.	Baja	Alto	Caída >5% vol. escaneos 2 trim.	Expansión Europa en curso
Sucesión	Media	Medio-alto	Comunicación de cambios directivos	Cultura fuerte; equipo técnico estable
Timing revenue	Media-alta	Medio	3 trim. bajo consenso	Backlog robusto; tendencia histórica
Disrupción tecnológica	Baja	Muy alto	Nuevo entrante con streaming superior	15+ años de I+D; validación clínica
Regulatorio	Baja	Medio	Cambios HIPAA/ cloud restrictions	Cumplimiento proactivo

Tabla 6: Matriz de riesgos con probabilidad, impacto, señales de alerta y mitigantes.

10. Valoración

10.1. Múltiplos actuales vs. históricos 5Y

La valoración actual de Pro Medicus se sitúa, por cada múltiplo relevante, en los percentiles más bajos de su rango histórico de los últimos cinco años. Esto no significa que la acción esté barata en términos absolutos (un P/E de 84x no lo es), pero si, que el mercado esta asignando la menor prima de la última media década a un negocio que no ha dejado de crecer y mejorar sus métricas operativas.

Múltiplo	TTM	p25 (5Y)	p50 (5Y)	p75 (5Y)	Percentil actual
P/E	84.0x	125.0x	159.4x	215.1x	**5%**
EV/EBITDA	72.9x	79.3x	103.9x	139.5x	**10%**
EV/Revenue	57.1x	59.7x	77.5x	108.1x	**13%**
EV/FCF	101.4x	122.5x	162.2x	211.8x	**8%**
EV/EBIT	77.0x	89.8x	116.6x	157.3x	**5%**

Tabla 7: Múltiplos de valoración actuales vs. percentiles históricos 5Y. Fuente: modelo cuantitativo propio.

El dato más elocuente es el percentil actual del P/E: **5%**. Esto significa que en el 95% del tiempo durante los últimos cinco años, el mercado ha estado dispuesto a pagar un múltiplo superior al actual por las ganancias de Pro Medicus. El EV/EBIT TTM de 77x, en el percentil 5%, cuenta una historia similar. Estamos comprando en el punto de mínima disposición a pagar del mercado.

Una lectura crítica de estos datos podría argumentar que los percentiles históricos reflejan un período de exuberancia y que los múltiplos previos estaban inflados. Es un argumento válido. Sin embargo, observamos que el negocio subyacente ha mejorado en todas las métricas relevantes durante ese mismo período: los márgenes son más altos, el crecimiento es más rápido, la base de clientes es más diversificada, y el moat es más profundo. Si algo debería cotizar con múltiplos similares o superiores a los históricos, es un negocio mejor, no uno peor.

10.2. Qué tiene que ser verdad a $124

Uno de los ejercicios de valoración más útiles es invertir la pregunta: en lugar de proyectar hacia adelante, preguntar qué expectativas están implícitas en el precio actual. A AUD $124, con un P/E TTM de 84x y un EPS TTM de $1.47, realizamos un reverse DCF con WACC del 7%, crecimiento terminal del 3% y FCF TTM de AUD $135.5M. Con un EV de $12,181M (capitalización de $12,400M más deuda de $4M menos caja de $223M), el precio actual implica un crecimiento del FCF de aproximadamente el **30% anual** durante los próximos cinco años. Ese nivel de crecimiento no supone ninguna aceleración respecto al ritmo histórico de la empresa; es, esencialmente, una continuación de lo que Pro Medicus ya ha demostrado durante la última década. En otras palabras, el mercado no está descontando un deterioro del negocio ni exigiendo una mejora: está pagando exactamente por la repetición del historial, sin asignar ninguna prima por la calidad del moat, por el pipeline de contratos firmados, ni por los catalizadores de expansión geográfica y nuevas especialidades.

¿Es razonable esperar que PME mantenga un crecimiento del 30%? El pipeline de contratos firmados pendientes de go-live, el crecimiento orgánico del volumen de escaneos en contratos existentes, y la expansión en cardiología y Europa sugieren que la base para sostener ese ritmo está intacta. Lo que el mercado está descontando, en nuestra opinión, es una combinación de pesimismo cíclico y miedo a la IA que no refleja la realidad operativa del negocio.

Podemos ir un paso más allá con este ejercicio. Si asumimos que PME mantiene un crecimiento del 25% (inferior al 30% histórico), y que el P/E se comprime gradualmente hasta 70x en tres años, el precio implícito a FY2028 sería de AUD $\$1.47 \times (1.25)^3 \times 70 =$ **AUD $201**. Ese escenario, que combina una desaceleración moderada con una compresión severa de múltiplos, genera un retorno del **62%** desde $124, o un **17.5% anualizado**. En otras palabras, incluso en un escenario conservador que asume todo lo negativo que podría pasar excepto un deterioro fundamental, el retorno no es modesto: es materialmente positivo.

El análisis inverso confirma lo que sugiere la valoración relativa: a $124, las expectativas implícitas del mercado son significativamente inferiores a la trayectoria demostrada del negocio, y el suelo razonable del escenario adverso ha subido de forma considerable respecto a lo que sugeriría una lectura superficial de los múltiplos. Hay un gap entre lo que el mercado espera y lo que el negocio ha entregado consistentemente durante la última década, y ese gap es la fuente de nuestra ventaja como inversores con un horizonte temporal más largo que el del mercado.

10.3. Comparables

La selección de comparables para Pro Medicus es complicada porque no existe un peer directo cotizado con el mismo perfil de crecimiento, márgenes y moat. Los comparables más relevantes son Veeva Systems (vertical SaaS para farmaceuticas), Sectra (competidor directo, cotiza en Estocolmo), Evolent Health (healthtech, menor calidad), y otros especialistas en software médico.

Veeva opera con márgenes inferiores (EBIT ~35%) pero tiene un moat igualmente profundo en su nicho. Cotiza a un P/E forward de 40-50x con un crecimiento del 12-15%. Si aplicamos el diferencial de crecimiento (PME crece al doble), un P/E de 80-120x para PME estaría justificado por la relación PEG (P/E / Growth). Sectra cotiza en Estocolmo a un P/E de 60-70x con un crecimiento del 15-18% y márgenes del 25%. La prima de PME sobre Sectra está justificada por la diferencia de márgenes (74% vs. 25%) y de crecimiento (30% vs. 18%).

Otra forma de contextualizar la valoración es a través del **PEG ratio** (P/E dividido por la tasa de crecimiento esperada). Con un P/E de 84x y un crecimiento de beneficios del 35-38%, el PEG de PME es de aproximadamente 2.4-2.6x. Para referencia, el PEG medio de las mejores empresas SaaS del mundo (aquellas con márgenes superiores al 30% y crecimiento superior al 20%) se sitúa entre 2.0x y 3.5x. PME está dentro de ese rango, no por encima. El mercado no está pagando una prima injustificada por la calidad; de hecho, el PEG actual es inferior al PEG mediano histórico de la propia PME, que ha oscilado entre 3.0x y 5.0x.

Para completar el análisis de valoración, es útil considerar el precio en función del flujo de caja libre. Con un FCF TTM de AUD $134M y una capitalización de AUD $13.0B al precio de entrada, el FCF yield es del 0.9%. Es un yield bajo, pero coherente con el perfil de una empresa en hipercrecimiento. Si el FCF crece al 25% anual durante tres años (un supuesto conservador dado el historial), el FCF en FY2028 sería de AUD $262M, lo que implicaría un FCF yield del 2% sobre el precio de compra, y si en ese momento el mercado valora el negocio a 60x FCF (la mitad de la mediana histórica de EV/FCF), la capitalización implícita sería de AUD $13.1B, o AUD $300 por acción, alineado con nuestro escenario base.

11. Proyecciones Financieras

Las siguientes proyecciones representan nuestro escenario base, acompañado de rangos bull y bear para las métricas principales. Los supuestos subyacentes se derivan del análisis de la sección 10 y reflejan la combinación de crecimiento orgánico de volumen, nuevos contratos en pipeline, y la potencial expansión geográfica.

AUD M (Base)	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E	FY30E
Revenue	273	346	432	535	540-680
YoY Growth	**+28%**	**+27%**	**+25%**	**+24%**	**+22-27%**
EBITDA	215	275	346	432	435-545
EBITDA Mg	**78.8%**	**79.5%**	**80.1%**	**80.7%**	**80-81%**
EBIT	205	263	332	414	415-525
EBIT Mg	**75.1%**	**76.0%**	**76.9%**	**77.4%**	**77-78%**
Net Income	148	192	245	308	280-370
Net Mg	**54.2%**	**55.5%**	**56.7%**	**57.6%**	**55-58%**
FCF	135	176	225	285	260-340
EPS (AUD)	1.42	1.84	2.35	2.95	2.70-3.55

Tabla 9: Proyecciones financieras FY26E-FY30E (escenario base con rango bull/bear para FY30E).

Los supuestos de revenue se construyen bottom-up a partir de tres componentes: el crecimiento orgánico de volumen de los contratos existentes (estimado en un 5-7% anual, impulsado por el aumento natural de escaneos), el impacto de los go-lives de contratos ya firmados, pero aun en implementación (que podría aportar entre un 10-15% de crecimiento incremental), y la contribución de nuevos contratos firmados durante el período de proyección (estimada en un 8-12% adicional).

Los supuestos de margen reflejan la expansión gradual que hemos observado históricamente: cada punto porcentual de margen adicional se explica por la difusión de la base de costes fija sobre una base de ingresos creciente. No asumimos ningún deterioro competitivo ni incremento significativo del capex.

Es importante señalar lo que nuestras proyecciones no asumen. No asumimos ninguna adquisición. No asumimos la entrada en líneas de negocio adyacentes (como el procesamiento de imágenes de patología, un mercado en el que PME ha mostrado interés pero no ha dado pasos concretos). No asumimos una expansión agresiva en Europa que podría, en caso de materializarse, acelerar significativamente el crecimiento. Y no asumimos ingresos adicionales por integración de herramientas de IA, algo que podría convertirse en una línea de revenue material en los próximos años.

En otras palabras, nuestras proyecciones base reflejan un escenario conservador donde PME simplemente continúa haciendo lo que ya está haciendo: ganar contratos enterprise en Estados Unidos, implementar los contratos ya firmados, y generar crecimiento orgánico de volumen en la base existente. Cualquier catalizador adicional (expansión europea, revenue de IA, adquisiciones estratégicas) representaría upside sobre nuestras proyecciones.

El riesgo a la baja en las proyecciones se concentra en dos variables: la velocidad de go-live de nuevos contratos (si se alargan los ciclos de implementación, el revenue growth de los primeros años sería inferior al proyectado) y la tasa de crecimiento orgánico del volumen de escaneos (si el crecimiento secular del volumen de imágenes diagnósticas se desacelera, el componente orgánico de crecimiento sería menor). En el escenario bear, ambos factores contribuyen a un crecimiento del 17%, que sigue siendo robusto en términos absolutos pero insuficiente para justificar múltiplos premium.

12. Catalizadores

Más allá de la progresión natural de los resultados financieros, existen catalizadores estructurales y eventos concretos que podrían expandir tanto el negocio como la valoración que el mercado le asigna. Los agrupamos en dos categorías: los que están ya en curso y los que representan opcionalidad futura real. Ninguno de ellos está incorporado en las proyecciones del escenario base, lo que significa que su materialización representaría upside adicional sobre las estimaciones conservadoras de la sección 11.

Resultados FY2026 completos (agosto 2026).

Si los resultados del segundo semestre compensan la debilidad relativa del primero y el crecimiento anual se mantiene por encima del 25%, la narrativa de deterioro se desmontará y los múltiplos podrían comenzar a revertir. Este es el catalizador más inmediato y probable.

Anunció de nuevos contratos enterprise en EE.UU.

Cada contrato con un sistema hospitalario grande refuerza la posición competitiva y genera visibilidad de ingresos para los próximos 7-10 años. Un contrato comparable a Kaiser Permanente tendría un impacto inmediato en el sentimiento del mercado.

Expansión europea confirmada.

Pro Medicus ha señalado su intención de expandirse en Europa, un mercado de Enterprise Imaging de aproximadamente USD $700M que esta significativamente menos penetrado que el norteamericano. La firma de un contrato grande con un sistema hospitalario europeo (NHS en Reino Unido, AP-HP en Francia, Charite en Alemania) sería un hito transformador.

Go-live de contratos pendientes.

Varios contratos firmados en 2024-2025 están en fase de implementación. Cada go-live se traduce inmediatamente en reconocimiento de ingresos transaccionales. A medida que estos contratos se activen, el revenue growth se acelerara mecánicamente.

Visage 7 como plataforma receptora de IA.

Pro Medicus está adaptando activamente Visage 7 para que funcione como la capa de orquestación donde los modelos de IA médica de terceros se ejecutan, muestran sus resultados y quedan integrados en el flujo de trabajo del radiólogo. Esto no es marketing; es una decisión arquitectónica deliberada que convierte a la plataforma en el punto de entrada obligado para cualquier herramienta de visión artificial que quiera llegar al radiólogo en entornos enterprise. La lógica económica es poderosa: cuantos más modelos de IA se integren en Visage 7, mayor es el coste de cambiar de plataforma, y mayor la posibilidad de que PME cobre por esas integraciones como fuente de ingresos incremental. En lugar de competir con

los desarrolladores de IA diagnóstica, Pro Medicus se posiciona como la infraestructura que los hace utilizables a escala hospitalaria. Si este posicionamiento cristaliza, la narrativa del mercado pasa de "la IA amenaza a PME" a "la IA necesita a PME", lo cual tendría un impacto directo y significativo en la valoración.

Expansión a nuevas especialidades: cardiología como siguiente frontera.

Visage 7 nació como plataforma de imagen radiológica, pero la arquitectura de server-side streaming es agnóstica a la modalidad. Pro Medicus está desarrollando capacidades específicas para cardiología, una especialidad con características técnicas exigentes: los estudios de imagen cardiaca (ecocardiografías 3D/4D, resonancias cardiacas, angiotomografías coronarias) generan volúmenes de datos aún mayores que los estudios radiológicos convencionales y requieren herramientas de visualización y medición altamente especializadas. El mercado de imagen cardiaca está dominado por soluciones fragmentadas y obsoletas de los mismos fabricantes de hardware que han sido desplazados en radiología, lo que sugiere que el patrón de disrupción podría repetirse. Una entrada exitosa en cardiología no solo ampliaría el TAM direccionable de forma significativa, sino que profundizaría el moat en los hospitales existentes, que podrían centralizar toda su imagen diagnóstica en una única plataforma. Además, dado que los departamentos de cardiología comparten infraestructura hospitalaria con los de radiología, la venta cruzada en los clientes actuales reduciría el coste de adquisición de los nuevos contratos. Este es un catalizador de medio plazo cuya materialización plena se esperaría en el horizonte FY2028-FY2030, pero cuya señal de avance podría llegar antes en forma de anuncios de desarrollo o contratos piloto.

Ejecución del buyback.

A medida que el programa de recompra del 10% se ejecute, la reducción del capital circulante elevará mecánicamente el EPS y el FCF per share, mejorando las métricas por acción sin necesidad de crecimiento operativo adicional.

Resultados HY2027 y FY2027.

Si el patrón histórico se repite y los go-lives retrasados de HY26 se materializan en un crecimiento acelerado en el segundo semestre y en FY2027, los resultados podrían superar expectativas del consenso, generando un re-rating rápido. El mercado tiende a castigar los misses y recompensar los beats de forma asimétrica en empresas de crecimiento.

La temporalidad de estos catalizadores es relevante. Los más inmediatos (resultados FY2026 en agosto 2026 y ejecución del buyback durante 2026) podrían generar un rebote significativo en un horizonte de 6-12 meses. Los catalizadores de medio plazo (expansión europea, nuevos contratos, integración de IA) se materializarían a lo largo de los próximos 2-3 años. Esta combinación de catalizadores escalonados es favorable porque reduce la dependencia de un único evento y proporciona múltiples puntos de inflexión potenciales.

Un catalizador que no podemos predecir pero que vale la pena mencionar es la **reversión del sentimiento hacia el sector**. Las acciones de crecimiento de calidad tienden a ser vendidas en grupo durante períodos de aversión al riesgo, pero también tienden a recuperarse en grupo cuando el sentimiento cambia. Si el mercado vuelve a favorecer compounders de calidad con moats profundos, y eso puede ocurrir de forma rápida e impredecible, PME sería uno de los principales beneficiarios.

13. Marco de Seguimiento y Señales de Salida

13.1. KPIs trimestrales

Monitorizaré los siguientes indicadores en cada publicación de resultados:

KPI	Objetivo (mantener)	Alerta amarilla	Alerta roja (revisar tesis)
Revenue growth YoY	>25%	18-25%	<15% (2 trim.)
Margen EBIT	>72%	65-72%	<65%
Renewal rate	100%	1 no renovación (pequeño)	1 no renovación (grande)
Nuevos contratos	2-3 grandes/año	1 grande/año	0 grandes 12 meses
Go-lives	Según guidance	Retraso 1 trim.	Retraso >2 trim.
Caja neta	>$150M	$100-150M	<$100M sin razón clara
FCF conversión	>80%	65-80%	<65%
KLAS ranking	Top 2	Top 3	Fuera Top 3

Tabla 10: KPIs de seguimiento trimestral con umbrales de alerta.

13.2. Señales de invalidación de la tesis

Las siguientes señales, si se materializan, invalidarían mi tesis y desencadenarían una reducción o cierre de posición:

Primera: **pérdida de un cliente grande**. Si un hospital con más de 5 centros decide no renovar con PME y migra a un competidor, la narrativa de retención del 100% se rompe, y debemos reevaluar la profundidad del moat.

Segunda: **caída del margen EBIT por debajo del 65%** durante dos trimestres consecutivos. Esto indicaría que el apalancamiento operativo se ha invertido, lo que sugeriría presión competitiva en precios o una expansión de costes no justificada.

Tercera: **crecimiento de revenue por debajo del 15%** durante dos trimestres consecutivos, sin explicación convincente ligada a timing de go-lives. Esto sugeriría una desaceleración estructural de la demanda.

Cuarta: **deterioro significativo de KLAS rankings**, cayendo fuera del top 3. Esto indicaría que la ventaja tecnológica percibida por los hospitales esta erosionándose.

Quinta: **salida abrupta de Hupert o Hall** sin plan de transición ordenado, acompañada de cambios culturales visibles (contratación masiva, reestructuración, cambio de estrategia).

13.3. Marco de decisión sobre posición

Añadir posición: Si el precio cae por debajo de AUD $100 sin deterioro fundamental, y los KPIs operativos se mantienen verdes, consideraremos incrementar la posición hasta un máximo del 8% de la cartera.

Mantener posición: Mientras los KPIs se mantengan en zona verde o amarilla, y no se materialice ninguna señal de invalidación, mantenemos la posición con horizonte de tres años.

Reducir posición: Si se activan dos o más alertas rojas simultáneamente, reduciremos la posición a la mitad para limitar el riesgo mientras evaluamos la situación. Si el precio alcanza el rango de $280-$320 en menos de dos años y los múltiplos vuelven a niveles de mediana histórica, consideraremos una realización parcial de beneficios del 15-20% de la posición.

Cerrar posición: Si se materializa cualquiera de las señales de invalidación listadas arriba, o si se activan tres o más alertas rojas de forma simultánea, cerraremos la posición completamente.

Un aspecto importante de este marco es la disciplina emocional. Las acciones que han caído un 63% generan reacciones psicológicas potentes: el miedo a que sigan cayendo, la tentación de promediar a la baja sin límite, o la inclinación a ignorar señales de alerta porque admitir un error es doloroso. Nuestro marco de decisión está diseñado para contrarrestar estos sesgos. Las reglas son claras, cuantitativas donde es posible, y están definidas antes de que la presión emocional del mercado las contamine.

También es importante definir que no haremos. No venderemos por volatilidad de precio si los fundamentales están intactos. No añadiremos posición por el simple hecho de que el precio haya bajado más; solo lo haremos si la evaluación fundamental sigue siendo positiva. Y no cambiaremos nuestro horizonte temporal de tres años porque un trimestre sea decepcionante. La inversión en Pro Medicus es una apuesta por la calidad del negocio a medio plazo, no un trade de momentum.

14. Tesis final de inversión

Pro Medicus es uno de esos negocios raros que combinan calidad operativa excepcional con una ventaja competitiva profunda y demostrable. El mercado lo sabe, por eso lo ha valorado con múltiplos premium durante años. Lo que ha cambiado en los últimos meses no es la calidad del negocio, sino el precio que el mercado está dispuesto a pagar por ella. La tesis se sostiene sobre cuatro pilares que, considerados en conjunto, construyen un argumento difícil de rebatir.

El primero es la calidad del negocio. Pro Medicus no es una empresa de software médica más: es **la única plataforma del mercado capaz de procesar y visualizar estudios de imagen diagnóstica a alta resolución en tiempo real**, desde cualquier navegador, sin descargar el estudio completo. Esa ventaja técnica se traduce en números objetivos: ingresos creciendo al 30% anual durante cinco años consecutivos, márgenes EBIT por encima del 74%, ROIC del 26%, flujo de caja libre superior a AUD $100M anuales con apenas 132 empleados, y cero deuda financiera relevante. Más significativo aún: desde 2009, ningún cliente ha abandonado la plataforma. Ni uno. Esa cifra no es marketing; es la prueba empírica de que los **switching costs son reales**, profundos y prácticamente infranqueables. Invertir en Pro Medicus no es una apuesta especulativa; es tomar participación en una máquina generadora de caja con un **moat que se profundiza cada año**.

El segundo pilar es la dislocación entre precio y fundamentales. La caída del 63% desde máximos, de AUD $336 a AUD $124, no tiene su origen en ningún deterioro operativo. Los márgenes han seguido expandiéndose. Los contratos se han seguido firmando. El backlog no ha disminuido. Lo que ha cambiado es exclusivamente el múltiplo que el mercado está dispuesto a pagar, presionado por tres factores exógenos y temporales: la narrativa de la IA como amenaza existencial para la radiología, los resultados del primer semestre de FY2026 ligeramente por debajo de consenso por retrasos en go-lives, y la rotación generalizada desde acciones de crecimiento hacia sectores defensivos. El resultado es que hoy el mercado valora a Pro Medicus en el percentil 5 de su P/E histórico de los últimos cinco años, 84x frente a una mediana de 159x, por un negocio que objetivamente ha mejorado en todas sus métricas durante ese mismo período. Esa dislocación tiene un nombre**: margen de seguridad**.

El tercer pilar son los catalizadores de crecimiento. La tesis no descansa en una recuperación de múltiplos sin ancla fundamental; se apoya en hechos tangibles. El backlog de contratos firmados pendientes de go-live garantiza una aceleración mecánica de ingresos en los próximos trimestres. La expansión en cardiología amplía el TAM addressable y profundiza el moat en los hospitales existentes. La posibilidad de acceder al mercado europeo, prácticamente inexplorado para PME, representa una opcionalidad real no

incorporada en las proyecciones del escenario base. Y el posicionamiento de Visage 7 como capa de orquestación de herramientas de IA de terceros convierte la principal narrativa bajista del mercado, que la IA amenaza el negocio, en su opuesto: la IA necesita a Pro Medicus como infraestructura de distribución. El escenario base proyecta un precio objetivo a tres años en el rango AUD $280–$320, lo que implica un retorno potencial de entre el 125% y el 158% desde los niveles actuales.

El cuarto pilar, y el más incómodo, es la honestidad sobre los riesgos. Pro Medicus sigue cotizando a múltiplos elevados en términos absolutos; una compresión adicional hacia 60–70x P/E representaría una pérdida del 20–30% sobre el precio actual, y ese escenario no es imposible. La concentración del 90% de los ingresos en Estados Unidos es una vulnerabilidad real frente a cambios regulatorios o recortes presupuestarios hospitalarios. La ausencia de un plan de sucesión público para Hupert y Hall, ambos con más de 65 años, es una incógnita que no debe minimizarse. Y el riesgo de que los ciclos de implementación se alarguen sistemáticamente, más allá del fenómeno puntual de HY26, podría defraudar expectativas durante varios trimestres consecutivos. Estos riesgos son reales y los he delimitado con señales de alerta concretas en el marco de seguimiento de la sección 13. La pregunta relevante no es si existen riesgos, siempre existen, sino si la corrección del 63% los sobrepondera frente a la evidencia operativa. El análisis desarrollado en esta tesis apunta a que sí.

Para terminar, Pro Medicus combina lo que más valoro en cualquier tesis de inversión: un negocio comprobadamente **superior en su nicho**, con una ventaja competitiva que se autorrefuerza, gestionado por fundadores con **skin in the game real**, en un momento de infravaloración histórica generada por factores transitorios. El análisis cuantitativo y el cualitativo cuentan exactamente la misma historia, y esa coherencia es, en sí misma, una señal. Los escenarios adversos razonables generan retornos positivos. Los escenarios base generan retornos superiores al 100%. Y los catalizadores de medio plazo: go-lives, expansión europea, integración de IA, resultados FY2026, ofrecen múltiples puntos de inflexión potenciales a lo largo del horizonte de análisis. El perfil resultante es asimétrico en la dirección correcta.